



MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE
L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE LA
COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

PRISE EN CHARGE INTÉGRÉE DES MALADIES DU NOUVEAU-NE ET DE L'ENFANT



LIVRET DE TABLEAUX PCIMNE

Edition décembre 2021

Prise en charge de l'enfant malade âgé de 0 à 5 ans

ORIENTATIONS POUR L'UTILISATION DU LIVRET DE TABLEAU PCIMNE

Les affections néonatales, le paludisme, la pneumonie, la diarrhée, la rougeole, le VIH /Sida et la malnutrition sont les causes de plus de 70% des décès chez l'enfant de moins de 5 ans. Dans les centres de santé, les agents ont à leur disposition des moyens pratiques et efficaces pour prévenir et/ou traiter ces maladies et éviter la plupart de ces décès. En se basant sur les résultats techniques actualisés, les ministères en charge de la santé, l'OMS et l'UNICEF ont décrit la prise en charge de ces maladies dans une série de guides intégrés en lieu et place de directives séparées pour chaque maladie. Ces institutions ont développé un programme de formation depuis 1995 pour enseigner le processus de *Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant (PCIME)*, aujourd'hui *Prise en Charge Intégrée des Maladies du Nouveau-né et de l'Enfant (PCIMNE)* aux agents de santé responsables des enfants malades. C'est une stratégie qui vise à réduire la morbidité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans en ciblant les principales causes de mortalité dans cette tranche d'âge. Elle s'appuie sur les 3 composantes suivantes :

- ✓ composante 1 : l'amélioration des compétences des agents de santé (PCIMNE clinique).
- ✓ composante 2 : le renforcement du système de santé.
- ✓ composante 3 : la promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PCIMNE communautaire)

La présente version du Livret de tableaux, se situe dans le cadre de la composante 1. C'est l'un des outils du cours PCIMNE. Il a été développé conformément aux besoins de formation des agents de santé (médecins, infirmiers, sages femmes et autres responsables de santé).

Les agents de santé possèdent une grande expérience en ce qui concerne le traitement des maladies infantiles courantes. En général, leur formation est basée sur des directives spécifiques à chaque maladie, telles que les directives de traitement du paludisme ou les directives de prise en charge de la diarrhée. Il leur est parfois difficile de combiner diverses directives lorsqu'ils soignent un enfant qui présente plusieurs problèmes. Ils peuvent ne pas savoir quels sont les problèmes les plus importants à traiter. Le temps et les médicaments étant restreints, les agents de santé peuvent ne pas être en mesure d'identifier et de traiter tous les problèmes d'un enfant malade. Or, il y a d'importantes interactions entre ces différentes maladies. Par exemple, des épisodes de diarrhées répétées conduisent souvent à la malnutrition et les diarrhées qui accompagnent fréquemment la rougeole sont particulièrement graves. Donc, pour être efficace, la prise en charge des cas doit prendre en compte tous les symptômes de l'enfant malade.

Tout agent de santé peut suivre le processus de prise en charge intégrée des cas, présenté dans ce programme de formation, afin de prendre en compte les symptômes de l'enfant sans omettre le moindre problème. L'agent de santé peut déterminer si l'enfant est gravement malade et a besoin d'être transféré d'urgence **au centre de référence**. Si ce n'est pas le cas, il le prend en charge au centre de santé selon les directives de traitement des maladies de l'enfant. Les directives de prise en charge intégrée des cas combinent les directives existantes de l'OMS telles que celles qui concernent les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, le paludisme et les vaccinations. Ainsi, les directives spécifiques à chaque maladie s'inscrivent dans un processus plus large et plus efficace de prise en charge intégrée de l'enfant malade.

Ces directives contiennent également des conseils pour la mère de l'enfant ou la personne qui s'en occupe. En effet, la prise en charge intégrée des cas n'est efficace que dans la mesure où les familles consultent à temps un agent de santé. Si la famille attend que l'enfant soit gravement malade pour l'amener au centre de santé ou l'emmène voir une personne non qualifiée, (non professionnelle), cet enfant court plus de risques de mourir de la maladie. Ainsi, apprendre aux membres de la famille quand rechercher des soins appropriés pour un enfant malade est un élément important du processus de prise en charge intégrée.

BUT DU COURS DE FORMATION A LA PCIMNE



Ce programme de formation a été élaboré dans le but d'enseigner le processus de prise en charge des cas aux agents de santé. Il s'agit d'un processus de prise en charge des cas dans un établissement de soins de premier niveau à savoir un dispensaire rural, un centre de santé rural, un centre de santé urbain, une formation sanitaire urbaine, ou un service de consultations externes dans un hôpital. Le terme « centre de santé » utilisé tout le long de ce cours désigne tous ces établissements. Le terme « **centre de référence** » utilisé tout le long de ce cours désigne tous ces établissements de soins dotés de plateau technique et de l'expertise nécessaires pour traiter les enfants très malades.

Le processus de prise en charge intégrée des cas est illustré par une série de tableaux qui décrivent les étapes à suivre et donnent toutes les informations nécessaires pour y arriver. Ces étapes sont les suivantes :

- Evaluer l'enfant, le nourrisson ou le nouveau-né
- Classer la maladie
- Identifier le traitement
- Traiter l'enfant
- Conseiller la mère
- Assurer le suivi des soins.

Ces étapes sont probablement identiques à celles que vous suivez actuellement en soignant les enfants malades, mais elles portent peut-être d'autres noms. L'étape appelée « Evaluer l'enfant » correspond à l'interrogatoire et à l'examen physique. L'étape appelée « Classer la maladie » consiste à prendre une décision sur la sévérité de la maladie. Vous devez choisir une catégorie ou « Classification » pour chaque symptôme majeur de l'enfant, qui correspond à la sévérité de la maladie. Les classifications ne sont pas des diagnostics spécifiques. Ce sont plutôt des catégories qui servent à déterminer le traitement.

OBJECTIFS DE CE LIVRET DE TABLEAUX

Le livret de tableau permet de prendre en charge un enfant selon les directives de la PCIMNE contenues dans les modules « **EVALUER ET CLASSER L'ENFANT MALADE** » qui décrivent comment évaluer et classer les enfants malades de façon à ne pas négliger d'autres signes de maladie. Il permet de mettre en pratique les techniques suivantes :

* Demander à la mère quels sont les problèmes de l'enfant

* Rechercher les signes généraux de danger : chez **TOUS** les enfants malades, il faut rechercher les signes généraux de danger.

Un signe général de danger est présent si :

- **L'enfant est incapable de boire ou de prendre le sein**
- **L'enfant vomit tout ce qu'il consomme**
- **L'enfant a eu des convulsions**
- **L'enfant convulse actuellement**
- **L'enfant est léthargique ou inconscient.**

} Tout enfant qui présente un signe général de danger présente un problème grave. La plupart des enfants avec un signe général de danger doivent être transférés d'**URGENCE** à l'hôpital de référence. Ils ont peut-être besoin d'un traitement de secours comprenant des injections d'antibiotiques, de l'oxygénation ou tout autre traitement non disponible au centre de santé. Dans ces cas, il faut achever rapidement l'évaluation, faire les traitements pré-transferts et les référer.

Tout enfant qui présente un signe général de danger présente un problème grave. La plupart des enfants avec un signe général de danger  sont être transférés d'**URGENCE** à l'hôpital de référence. Ils ont peut-être besoin d'un traitement de secours comprenant des injections d'antibiotiques, de

l'oxygénation ou tout autre traitement non disponible au centre de santé. Dans ces cas, il faut achever rapidement l'évaluation, faire les traitements pré-transferts et les référer.

* Poser des questions à la mère sur les quatre principaux symptômes :

- Toux ou difficulté respiratoire
- Diarrhée
- Fièvre
- Problème d'oreille

* Lorsqu'un symptôme principal est présent :

- apprécier l'état de l'enfant de façon plus détaillée en recherchant des signes associés au symptôme principal
- classer la maladie en fonction des signes présents ou absents

* Systématiquement chez tout enfant vu :

- rechercher les signes d'anémie et classer l'anémie
- rechercher les signes de malnutrition et classer l'état nutritionnel
- rechercher les signes d'une infection à VIH et classer

* Vérifier l'état vaccinal de l'enfant et décider si l'enfant doit être vacciné le jour même

* Evaluer les autres problèmes

* S'informer sur l'état de santé de la mère

Les tableaux de ce livret recommandent un traitement approprié pour chaque classification de maladie. Grâce à ce processus, la sélection d'une classification sur le tableau suffit pour « Identifier le traitement » de l'enfant.

Ici « Traiter » signifie administrer un traitement au centre de santé, prescrire des médicaments et d'autres soins à administrer à domicile ainsi qu'apprendre à la mère de l'enfant malade comment administrer ces soins. « Conseiller la mère » comprend une évaluation de l'alimentation de l'enfant, des recommandations pour l'alimentation et les liquides à donner à l'enfant, et une explication des circonstances dans lesquelles elle doit revenir au centre de santé avec l'enfant.



COMMENT CHOISIR LES TABLEAUX DE PRISE EN CHARGE INTEGREE APPROPRIES

Lorsqu'une mère amène un enfant au centre de santé parce qu'il est malade et que l'enfant vous est adressé, vous devez connaître l'âge de l'enfant. Avec l'âge de l'enfant, vous pourrez choisir le tableau approprié et commencer le processus d'évaluation qui se fait à l'aide d'une **fiche de prise en charge** correspondant à chaque tranche d'âges. Dans certains centres de santé, la procédure d'enregistrement des patients est telle que le nom, l'âge et d'autres informations (adresse) de l'enfant sont déjà enregistrés. Dans le cas contraire, commencer la visite en demandant l'âge de l'enfant. Décider à quel groupe d'âge appartient l'enfant :

- [0 -1 semaine [
- [1 semaine - 2 mois [
- [2 mois - 5 ans [

- S'il s'agit d'un nouveau-né de 0 à 1 semaine, utiliser la **Fiche de prise en charge** correspondant à cette tranche d'âge. Évaluez et classez l'enfant en fonction des étapes mentionnées sur le tableau **EVALUER ET CLASSER LE NOUVEAU-NE MALADE AGE DE 0 A 1 SEMAINE** (Page 72).

- Si l'âge de l'enfant est compris entre 1 semaine et 2 mois, il est considéré comme un nourrisson. Alors, utiliser la **Fiche de prise en charge** correspondant à cette tranche d'âge et évaluez et classez l'enfant en fonction des étapes mentionnées sur le tableau **EVALUER ET CLASSER LE NOURRISSON MALADE AGE DE 1 SEMAINE A 2 MOIS** (Page 70).

- Si l'âge de l'enfant se situe **entre 2 mois et 5 ans**, choisir le tableau **EVALUER ET CLASSER L'ENFANT MALADE AGE DE 2 MOIS A 5 ANS** et utiliser la **Fiche de prise en charge** correspondant à cette tranche d'âge (Page 67). « A 5 ans » signifie que l'enfant n'a pas encore passé son cinquième anniversaire. Par exemple, ce groupe d'âge comprend un enfant de 4 ans et 11 mois mais pas un enfant de 5 ans. Un enfant de 2 mois appartient au groupe de 2 mois à 5 ans, et pas au groupe de 1 semaine à 2 mois.

La plupart des tableaux de classification **EVALUER ET CLASSER** ont 3 rangées ou bandes horizontales. Chaque rangée est colorée soit en rose, soit en jaune, soit en vert. La couleur de la rangée aide à identifier rapidement si l'enfant a une maladie grave qui nécessite une action urgente.

- Une classification dans une rangée **rose** signifie que **la classification de l'enfant est grave** et exige une action urgente et le transfert à l'hôpital de référence.
- Une classification dans une rangée **jaune** signifie que l'enfant peut être pris en charge au centre de santé et nécessite un traitement spécifique tel qu'un antibiotique approprié, un antipaludique par voie orale ou autre traitement. Le traitement comprend en outre, les conseils à la mère sur la façon d'administrer les médicaments par voie orale ou traiter une infection locale à domicile. L'agent de santé conseillera la mère sur les soins à donner à l'enfant à domicile et lui indiquera quand revenir.
- Une classification dans une rangée **verte** ne fait pas l'objet d'un traitement médical spécial comme des antibiotiques ou autres traitements. L'agent de santé apprend à la mère comment soigner son enfant à domicile. Il peut s'agir par exemple des conseils pour la préparation d'une tisane de miel au citron ou des conseils sur l'alimentation à donner à son enfant malade.

Par exemple « Classer la toux ou difficulté respiratoire » :



- Regardez la rangée rose (en haut). Est-ce que l'enfant présente un signe général de danger ? Est-ce que l'enfant a un tirage ou un stridor quand il est calme ? Si l'enfant présente un signe général de danger ou tout autre signe mentionné dans la rangée rose (en haut), choisissez la classification grave : **PNEUMONIE GRAVE OU MALADIE TRES GRAVE.**

- si l'enfant n'a pas une classification grave, regardez la rangée jaune (au milieu). Est-ce que l'enfant respire rapidement ? Si l'enfant respire rapidement et n'a pas de classification grave, choisissez la rangée jaune, **PNEUMONIE.**

- Si l'enfant n'a pas de classification grave ni de classification dans la rangée jaune, regardez la rangée verte (en bas). L'enfant qui n'a pas de signe de pneumonie et pas de maladie très grave est classé dans la rangée verte, **PAS DE PNEUMONIE : TOUX OU RHUME.**

- Commencez toujours par le tableau de classification du haut. Si l'enfant présente des signes mentionnés dans plusieurs rangées, sélectionnez toujours la classification la plus grave. Dans le cas où l'enfant présente un signe de la rangée rose (en haut) et un signe de la rangée jaune (au milieu) choisissez la classification la plus grave : **PNEUMONIE GRAVE OU MALADIE TRES GRAVE.**

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Programme National de Santé de la Mère et de l'Enfant (PNSME) :

Tel : 20 21 22 21/ 20 32 24 63. Email : dcpnrs@gmail.com



PRISE EN CHARGE INTÉGRÉE DES MALADIES DU NOUVEAU-NE ET DE L'ENFANT

L'ENFANT MALADE ÂGÉ DE 2 MOIS À 5 ANS

EVALUER ET CLASSER L'ENFANT MALADE

Evaluer, classer et identifier le traitement

Rechercher les signes généraux de danger	9
Poser des questions sur les principaux symptômes:	
L'enfant a-t-il une toux ou des difficultés respiratoires?	9
L'enfant a-t-il la diarrhée?	10
L'enfant a-t-il de la fièvre?	11
Classer le paludisme	11
Classer la rougeole	11
L'enfant a-t-il un problème d'oreille?	12
Rechercher l'anémie	13
Vérifier l'état nutritionnel de l'enfant	14
Rechercher une infection symptomatique probable VIH	15
Vérifier la supplémentation en Vit A et état vaccinal de l'enfant	16
Evaluer les autres problèmes	16

TRAITER L'ENFANT

Apprendre à la mère comment administrer des Médicaments par voie orale à domicile

Antibiotique par voie orale	17
Antipaludéen par voie orale	18
Paracétamol	18
Vitamine A	18
Fer, Acide folique	18
Déparasitant et Multivitamines	18
Traiter l'enfant ayant une infection à VIH19	

Apprendre à la mère à traiter les infections locales à Domicile

Traiter une infection de l'oeil avec une pommade ophtalmique antibiotique	20
Assécher l'oreille et instiller une solution antibiotique	20
Traiter les ulcérations de la bouche au bleu de méthylène	20
Calmer la douleur de gorge et la toux avec un remède inoffensif	20

Administrer les traitements au centre de santé

Donner un antibiotique en intramusculaire	21
Donner un dérivé d'artémisinine 50 mg en suppositoire pour le paludisme grave	21
Arrêter les convulsions avec le diazépam	22
Prévenir l'hypoglycémie	22

TRAITER L'ENFANT (suite)

Pour la diarrhée, donner le zinc, plus de liquides et Continuer l'alimentation

Plan A: Traiter la diarrhée à domicile	23
Plan B: Traiter les signes évidents de déshydratation ...	23
Plan C: Traiter rapidement la déshydratation sévère	24

Suivi des soins

Pneumonie	25
Diarrhée persistante	25
Dysenterie	25
Paludisme	26
Rougeole avec complications aux yeux ou à la bouche	26
Infection de l'oreille	27
Anémie	27
Problème d'alimentation	27
Malnutrition modérée	27
Infection à VIH	28

CONSEILLER LA MÈRE

Les aliments

Evaluer l'alimentation de l'enfant	29
Recommandations pour l'alimentation	30
Conseils sur les problèmes d'alimentation	31

Les liquides

Augmenter la consommation de liquides pendant la maladie	32
---	----

Quand revenir

Expliquer à la mère quand revenir au centre de santé	32
Quand revenir pour une Visite de suivi	32
Quand revenir pour une Visite systématique	32
Quand revenir immédiatement	32
Donner des conseils à la mère sur sa propre santé	33

NOURRISSON MALADE ÂGÉ DE 1 SEMAINE À 2 MOIS

EVALUER, CLASSER ET TRAITER LE NOURRISSON MALADE

Evaluer, classer et identifier le traitement

Rechercher les infections bactériennes possibles	34
Evaluer le nourrisson pour la diarrhée	35
Evaluer le nourrisson pour l'infection à VIH	36
Rechercher les problèmes d'alimentation ou d'insuffisance pondérale	37
Vérifier l'état vaccinal du nourrisson	38
Evaluer les autres problèmes	38
Vérifier l'état de santé de la mère	38

Traiter le nourrisson et conseiller la mère

Antibiotique par voie orale	39
Vitamine K1 en intramusculaire	39
Antibiotique en intramusculaire	39
Traiter la diarrhée	40
Vacciner tout nourrisson malade, si nécessaire	40
Traiter les infections locales à domicile	40
Bonne position et bonne prise du sein pour l'allaitement	41
Conseiller la mère sur les soins du nourrisson à domicile	41

Suivi des soins du nourrisson malade

Infection bactérienne locale	42
Problème d'alimentation	43
Insuffisance pondérale	43
Muguet	43

PRISE EN CHARGE INTÉGRÉE DES MALADIES DU NOUVEAU-NE ET DE L'ENFANT

NOUVEAU-NE DE 0 A 1 SEMAINE

Pages

EVALUER, CLASSER ET TRAITER LE NOUVEAU-NE MALADE DE 0 A 1 SEMAINE

LA REANIMATION NEONATALE 44

RECHERCHER UNE MALADIE GRAVE OU UNE INFECTION BACTERIENNE GRAVE,
UNE HYPOTHERMIE ET UNE INFECTION BACTERIENNE LOCALE 45

RECHERCHER UN POIDS FAIBLE 46

RECHERCHER UNE INFECTION OCULAIRE 46

RECHERCHER UN RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH 47

RECHERCHER LES DIFFICULTES D'ALIMENTATION 48

VERIFIER LE STATUT VACCINAL DU NOUVEAU-NE / EVALUER LES AUTRES PROBLEMES 49

TRAITER LE NOUVEAU-NE ET CONSEILLER LA MERE 50

Donner la dose d'antibiotiques pré-transfert 50

Donner un antibiotique approprié par voie orale 50

Apprendre à la mère à traiter les infections locales à domicile 51

Traiter l'infection oculaire et apprendre à la mère comment le faire à domicile 51

Réchauffer le nouveau-né et le garder au chaud 52

Enseigner à la mère comment garder le nouveau-né au chaud pendant le transfert à l'hôpital 54

Enseigner à la mère comment garder le nouveau-né au chaud à la maison 54

Si la mère est séropositive connue au VIH 55

Traiter le nouveau-né qui convulse avec du Diazépam 56

Traiter le nouveau-né pour éviter l'hypoglycémie 56

Vacciner le nouveau-né malade avec le BCG et Polio 0 si pas de contre-indication 56

Apprendre à la mère comment bien positionner le nouveau-né et assurer une bonne prise du sein 57

Conseiller la mère sur les soins à donner au nouveau-né à domicile 57

SUIVI DES SOINS DU NOUVEAU-NE MALADE 58

Rechercher tout signe de "POSSIBILITE DE MALADIE GRAVE ou INFECTION BACTERIENNE GRAVE" pendant
la visite de suivi chez tout nouveau-né 58

Conseiller la mère sur l'espacement des naissances 58

Infection bactérienne locale 58

Infection oculaire 58

Hypothermie modérée 58

Problèmes d'alimentation 59

Poids faible 59

Muguet 59

Infection VIH possible / exposé au VIH 60

ANNEXES

Pages

ANNEXES 1 : COURBES DE CROISSANCE 61

Poids/Âge Garçons 62

Poids/Âge Filles 63

Poids/Taille Filles 64

Poids/Taille Garçons 65

ANNEXES 2 : FICHES DE PRISE EN CHARGE 66

Enfant malade âgé de 2 mois à 5 ans 67

Nourrisson malade âgé d'1 semaine à 2 mois 70

Nouveau-né malade âgé de 0 à 1 semaine 72



EVALUER ET CLASSER L'ENFANT MALADE AGE DE 2 MOIS A 5 ANS



EVALUER

DEMANDER A LA MERE QUELS SONT LES PROBLEMES DE L'ENFANT

- Rechercher le motif de consultation
- Déterminer s'il s'agit d'un épisode initial ou d'un épisode répété
- Déterminer s'il s'agit d'une première visite ou d'une visite de suivi pour cet épisode.
- * S'il s'agit d'une visite de suivi, utiliser les instructions de suivi décrites dans le tableau *TRAITER L'ENFANT*
- * S'il s'agit d'une première visite, évaluer l'enfant comme suit :

CLASSER

POUR CLASSER LA MALADIE,
UTILISER TOUS LES CADRES
QUI CORRESPONDENT AUX
SYMPTOMES ET PROBLEMES
DE L'ENFANT

IDENTIFIER LE TRAITEMENT

RECHERCHER LES SIGNES GENERAUX DE DANGER

DEMANDER :

- L'enfant est-il capable de boire ou de prendre le sein ?
- L'enfant vomit-il tout ce qu'il consomme ?
- L'enfant a-t-il convulsé ?

OBSERVER :

- Voir si l'enfant est léthargique ou inconscient
- Voir si l'enfant convulse actuellement ?

Tout enfant présentant un signe général de danger requiert une action URGENTE ; achever immédiatement l'évaluation et tout traitement pré-transfert, afin de ne pas retarder le transfert. Si l'enfant est en train de convulser, lui dégager les voies aériennes et lui administrer du diazépam. Puis immédiatement après évaluer, classer et donner les traitements nécessaires avant de le traiter en urgence

ENSUITE, POSER DES QUESTIONS SUR LES PRINCIPAUX SYMPTOMES :

L'enfant a-t-il une toux ou des difficultés respiratoires ?

SI OUI, DEMANDER:

- Depuis combien de temps?
- Antécédent de toux ou difficultés respiratoires*

OBSERVER ET ÉCOUTER:

- Compter les mouvements respiratoires par minute.
- Rechercher un tirage sous-costal.
- Regarder et écouter si l'enfant a un stridor.

L'ENFANT
DOIT
ÊTRE
CALME

Classer la TOUX
ou les
DIFFICULTÉS
RESPIRATOIRES

Si l'enfant a : → Une respiration rapide est :

De 2 mois à moins de 12 mois → 50 mvts respiratoires par minute ou plus

De 12 mois à 5 ans → 40 mvts respiratoires par minute ou plus

* Si le transfert n'est pas possible, traiter l'enfant selon les instructions décrites dans l'Annexe du module Identifier et Traiter : Lorsque le transfert n'est pas possible et Directives OMS pour les soins à l'enfant.

SIGNES

CLASSER

TRAITEMENT

(Les traitements urgents avant transfert sont en caractère gras)

- Tout signe général de danger ou
- ou
- Stridor chez un enfant calme

**PNEUMONIE
GRAVE OU
MALADIE TRÈS
GRAVE**

- **Donner la première dose d'antibiotique approprié.**
- **Traiter l'enfant pour éviter l'hypoglycémie**
- **Rechercher une infection à VIH**
- **Administer une dose de paracétamol ou d'aspirine**
- **Transférer d'URGENCE à l'hôpital***

- Tirage sous-costal ou
- Respiration rapide.

PNEUMONIE

- Donner un antibiotique approprié pendant 5 jours
- Si tirage sous costal chez enfant exposé/infecté par VIH donner Amoxicilline et référer
- Si respiration sifflante qui disparaît après inhalation de bronchodilatateur, donner bronchodilatateur pour 5 jours
- Calmer le mal de gorge et la toux avec un remède inoffensif.
- Expliquer à la mère quand revenir immédiatement.
- Revoir dans 2 jours.
- Si toux de plus de 14 jours ou Antécédent de respiration sifflante référer pour recherche de Tuberculose ou Asthme

- Pas de signe de pneumonie ou de maladie très grave

**PAS DE
PNEUMONIE :
TOUX OU RHUME**

- Si toux depuis plus de 30 jours, référer le malade pour bilan
- Calmer le mal de gorge et la toux avec un remède inoffensif
- Expliquer à la mère quand revenir immédiatement
- Revoir dans 5 jours s'il n'y a pas d'amélioration

Pour la
DESHYDRATATION

Deux des signes suivants:

- Si l'enfant n'a pas, d'autre classification grave:
 - Donner des liquides pour déshydratation

SIGNES

CLASSER

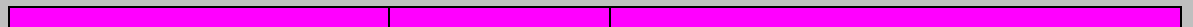
TRAITEMENT

(le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)

Si l'enfant présente une diarrhée persistante ou des antécédents de diarrhée persistante rechercher une infection symptomatique probable VIH

L'enfant a t'il de la fièvre ?

(Antécédent ou corps chaud au toucher ou température de 37,5°C ou plus)



SIGNES

CLASSER

TRAITEMENT

(le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)

**SI OUI,
DEMANDER:**

- Depuis combien de temps ?
- Si depuis plus de 7 jours, la fièvre a-t-elle été présente tous les jours ?

Des signes de paludisme Grave¹ :

- L'enfant émet-il des urines peu abondantes ou foncées ?
- L'enfant a-t-il eu des troubles du comportement ?
- L'enfant a-t-il convulsé ?

**OBSERVER ET
RECHERCHER:**

- Une raideur de nuque.
- Les signes de gravité du paludisme¹ :
 - Urines peu abondantes et foncées (coca-cola)
 - Ictère (yeux jaunes)
 - Hémorragies spontanées
 - Anémie grave :
- Signes Cardiorespiratoires*
Polypnée, Tachycardie
Hypotension
- Signes Neurologiques*
Somnolence
Agitation
Convulsions
Coma
- autres signes*
Difficultés à s'alimenter
Infections à répétition (ORL, Pulmonaires...)
Fissures des commissures labiales...

- Réaliser le Test de Diagnostic Rapide (TDR) du Paludisme

Si TDR
Positif

- Déterminer le taux d'hémoglobine (hémoglobinomètre)

Si TDR
Négatif**Des signes de Rougeole:**

L'enfant a-t-il eu la rougeole au cours des 3 derniers mois ?

Si l'enfant a actuellement la rougeole ou l'a eue au cours des 3 derniers mois:

- Eruption généralisée et l'un des signes suivants: toux, écoulement nasal ou yeux rouges.
- Regarder s'il y a des ulcérations au niveau de la bouche. Sont-elles profondes ou étendues ?
- Regarder s'il y a du pus qui coule des yeux.
- Regarder s'il existe une opacité de la cornée

Si **ROUGEOLE** actuelle (notifier) ou au cours des 3 derniers mois, classer

Si l'enfant a actuellement une fièvre prolongée inexpliquée (intermittente ou constante) pendant plus d'un mois ou en a eu dans ses antécédents, rechercher une infection à VIH.

**D'autres complications graves de la rougeole (pneumonie, stridor, diarrhée, infection de l'oreille, malnutrition) sont classées dans d'autres tableaux.*

¹ Selon l'OMS, le paludisme grave est défini comme une urgence médicale caractérisée par une parasitémie positive à plasmodium falciparum associée à une au moins des manifestations suivantes : trouble du comportement, altération de la conscience, coma, convulsion, oligurie, anémie grave, choc, ictère, hémorragie diffuse, prostration, hémoglobinurie, hypoglycémie, acidose, détresse respiratoire.

**L'enfant a t'il un problème
d'oreille ?**

SI OUI, DEMANDER : • L'enfant a-t-il mal aux oreilles ? • Y-a- t-il un écoulement ? Si oui, depuis combien de temps ? L'enfant a-t-il eu un écoulement d'oreille dans ses antécédents ?	OBSERVER ET PALPER : • Regarder si du pus coule d'une oreille. • Rechercher une douleur de l'oreille à la traction du pavillon ou pression du tragus • Palper à la recherche d'un gonflement douloureux derrière l'oreille
---	---

Classer le PROBLEME D'OREILLE

Si l'enfant a actuellement un écoulement d'oreille et en a eu dans ses antécédents (6 mois) rechercher une infection à VIH

SIGNES	CLASSER	TRAITEMENT (le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)
• Gonflement douloureux derrière l'oreille	MASTOÏDITE	➤ Donner la première dose d'antibiotique approprié. ➤ Donner la première dose de paracétamol pour calmer la douleur. ➤ Transférer d'URGENCE à l'hôpital.
• Ecoulement de pus visible et depuis moins de 14 jours ou • Douleur à l'oreille	INFECTION AIGUË DE L'OREILLE	➤ Donner un antibiotique pendant 5 jours. ➤ Assécher l'oreille à l'aide d'une mèche. ➤ Mettre des gouttes antibiotiques dans les oreilles ➤ Donner du paracétamol pour calmer la douleur. ➤ Si écoulement d'oreille, rechercher une infection à VIH ➤ Revoir l'enfant dans 5 jours.
• Ecoulement de pus visible et depuis 14 jours ou plus	INFECTION CHRONIQUE DE L'OREILLE	➤ Assécher l'oreille à l'aide d'une mèche. ➤ Rechercher une infection à VIH ➤ Goutte auriculaire à base de quinolone pendant 14 jours, ➤ Référé pour antibiogramme si antibiothérapie préalable ➤ Revoir l'enfant dans 5 jours
• Pas de douleur à l'oreille et Pas d'écoulement de pus visible	PAS D'INFECTION D'OREILLE	➤ Traiter l'enfant pour tous autres problèmes. ➤ Conseiller la mère.

ENSUITE, VERIFIER L'ETAT NUTRITIONNEL ET RECHERCHER L'ANEMIE

SIGNES

CLASSER

TRAITEMENT
(le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)

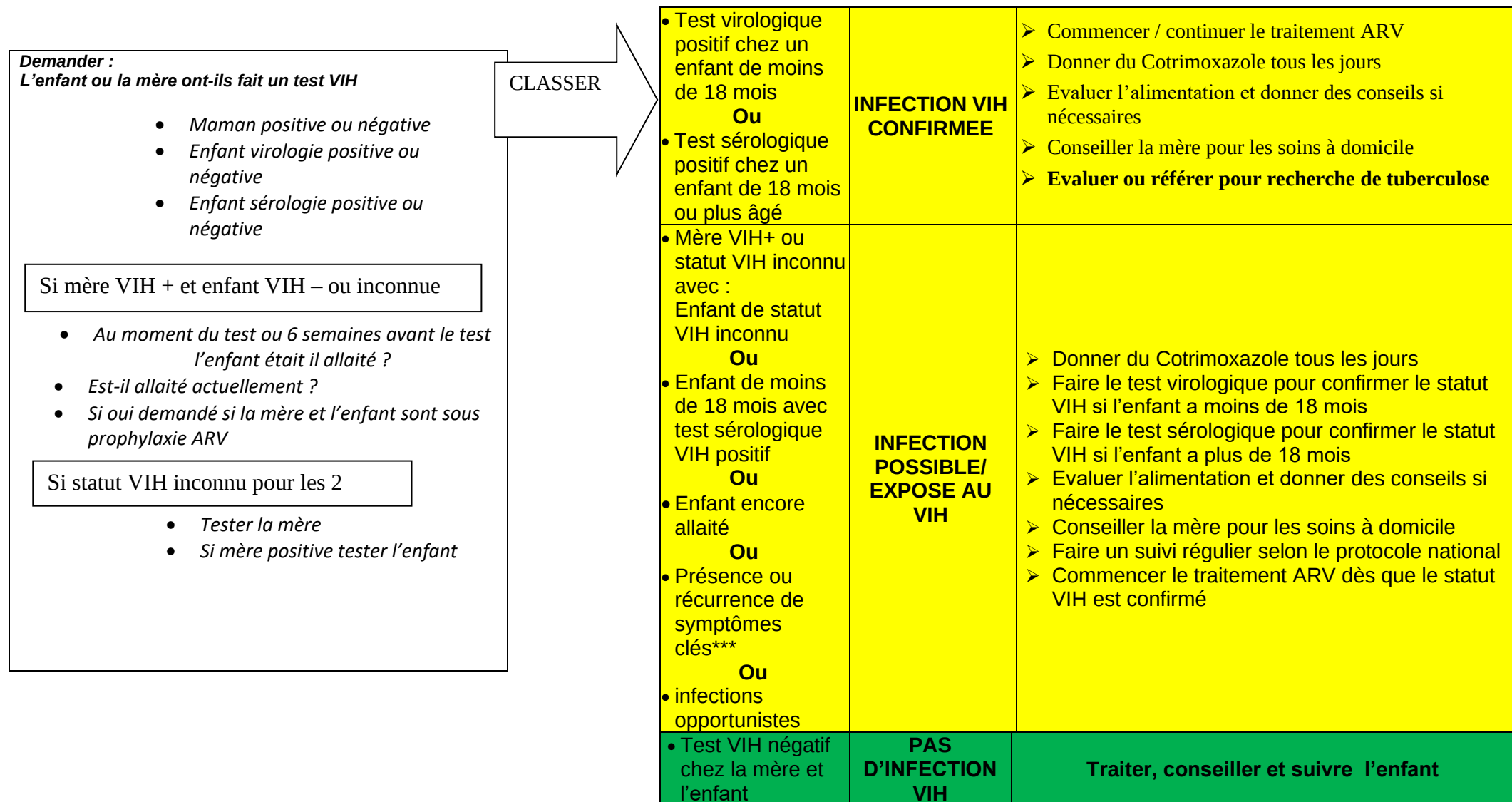
OBSERVER ET PALPER: • Rechercher un antécédent de perte de poids • Prendre le Périmètre brachial • Prendre systématiquement le poids et la taille • Rechercher des oedèmes bilatéraux au niveau des membres inférieurs, supérieurs et du visage . • Déterminer l'indice poids/ taille (voir courbes de croissance ou abaque) • Rechercher des complications : signes généraux de danger,hypoglycémie,hyperthermie,anémie, hypothermie,difficultés respiratoires, déshydratation, choc septique, défaillance cardiaque Faire le Test de l'appetit (en cas de PB< 115 mm ou Z- score < -3)	Classer l'ÉTAT NUTRITIONNEL re. pieds	• Œdèmes bilatéraux +++ OU • PB<115 mm ou indice poids/ taille z-score < -3 ET Test de l'appetit négatif ou au moins une des manifestations suivantes :Anorexie, hyperthermie, anémie sévère , hypothermie, déshydratation sévère, choc septique, défaillance cardiaque infections respiratoires,Non éveillé	MALNUTRITION AIGUE SÉVÈRE AVEC COMPLICATION	➤ Rechercher une infection à VIH ➤ Traiter l'enfant pour prévenir l'hypoglycémie ➤ Transférer d'URGENCE l'enfant dans une Unité de Nutrition Thérapeutique (UNT)
		• Œdèmes bilatéraux +/++ OU • PB<115 mm OU • indice poids/ taille score< -3 ET • Test de l'appetit positif et absence de complication	MALNUTRITION AIGUE SEVERE SANS COMPLICATION	Prise en charge en ambulatoire selon le protocole national Unité de Nutrition Thérapeutique Ambulatoire (UNTA) : Donner des Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi (ATPE) ➤ Donner un Antibiotique approprié pendant 07 jours ➤ Donner un Anti paludique si TDR positif ➤ Déparasiter l'enfant à la 4^{ème} semaine de suivi à l'albendazole / Mébendazole à partir de 12 mois s'il n'a pas été déparasité dans les 6 derniers mois ➤ Vacciner contre la rougeole à la 4^{ème} semaine de suivi du traitement si l'enfant n'est pas vacciné ➤ Si l'enfant vient d'une UNT et qu'il a reçu la 1^{ère} dose de vaccin RR, lui administrer une 2^{ème} dose de vaccin RR ➤ Donner de la vitamine A s'il n'a pas reçu dans les 6 derniers mois ➤ Rechercher une infection à VIH ➤ Revoir l'enfant tous les 7 jours
Si l'enfant a une perte de poids ou un poids faible pour l'âge ou une cassure de la courbe de poids, rechercher une infection à VIH		• 115 mm≤ PB<125 mm OU • -3 ≤ z-score P/T< -2 ET • Absence d'Œdèmes bilatéraux OU • Enfant sorti guéri de l'UNTA	MALNUTRITION AIGUE MODEREE	Prise en charge selon le protocole national Unité Nutritionnelle de Supplémentation (UNS) : Donner des bouillies locales enrichies ➤ Donner de la vitamine A ➤ Déparasiter l'enfant à l'albendazole / Mébendazole ➤ Prévenir l'Anémie avec le Fer et l'Acide folique ➤ Faire une réhabilitation nutritionnelle ➤ Revoir l'enfant tous les 14 jours. ➤ Surveiller la croissance de l'enfant ➤ Expliquer à la mère quand revenir immédiatement. ➤ Suivre l'enfant à l'Unité Nutritionnelle de Supplémentation (UNS) ➤ Rechercher une infection à VIH
Cas particuliers : Nourrissons de moins de 6 mois ou moins de 3 kg à transférer à l'UNT et dépistage de la malnutrition chronique : voir à la page 19		• PB ≥ 125 mm ou Z score ≥ -2	BON ETAT NUTRITIONNEL	➤ Féliciter la mère ➤ Education nutritionnelle ➤ Si l'enfant a moins de 2 ans, évaluer l'alimentation de l'enfant et conseiller à la mère de nourrir l'enfant comme décrit dans le cadre ALIMENTS du tableau CONSEILLER LA MÈRE. ➤ Revoir l'enfant dans 5 jours, si problème d'alimentation, ➤ Expliquer à la mère quand revenir immédiatement.

		SIGNES			
		CLASSER			
		TRAITEMENT			
OBSERVER ET RECHERCHER: - la pâleur palmaire est-elle: Sévère? Légère? Absente ? Si pâleur palmaire présente, demander : l'enfant est-il drépanocytaire. Si oui, rechercher les signes de gravité* - Rechercher autres signes de gravité : - Signes Cardiorespiratoires Polypnée Tachycardie Hypotension - Signes Neurologiques Somnolence Agitation Convulsions Coma - Autres signes Difficultés à s'alimenter Infections à répétition (ORL, Pulmonaires...) Fissures des commissures labiales Ongles cassants Peau sèche et rugueuse Langue rouge sensible aux mets acides et épicés - Déterminer le Taux d'hémoglobine (hb) avec un hémoglobinomètre	Classe l'ANEMIE	- Pâleur palmaire sévère - Ou - Drépanocytose avec signes de gravité - Ou - Si Taux d'hb < 5.5g/dl - Et - Signes cardiorespiratoires - Ou - Signes neurologiques - Ou - Autres signes	ANÉMIE GRAVE	- Donner de la vitamine A. - Donner du paracétamol ou de l'acide acétyl salicylique si la T° est de 38°5 ou plus - Traiter l'enfant pour prévenir l'hypoglycémie - Transférer d'URGENCE à l'hôpital de référence.	
			- Pâleur palmaire légère - Et - Difficultés à s'alimenter ou Infections à répétition (ORL, Pulmonaires...) ou Fissure des commissures Labiales ou Ongles cassantes ou Peau sèche et rugueuse ou Langue rouge sensible aux mets acides	ANÉMIE MODEREE	- Donner du fer - Donner de l'acide folique - Donner un antipaludique pour une cure si TDR + - Déparasiter l'enfant à l'albendazole / Mébendazole - Donner de la vitamine A - Expliquer à la mère quand revenir immédiatement - Rechercher une infection à VIH - Revoir l'enfant dans 14 jours.
			Pas de pâleur palmaire	PAS D'ANÉMIE	- Traiter l'enfant pour tous autres problèmes - Conseiller la mère. - Expliquer à la mère quand revenir immédiatement.

SIGNES

* Les signes de gravité de la drépanocytose sont : ictère, fièvre, crises aiguës et fréquentes, priapisme.

Rechercher une infection à VIH dans l'évaluation des principaux symptômes ou si vous trouvez une malnutrition ou d'autres signes :



*Donner cotrimoxazole en prophylaxie pour tous les sujets VIH positifs et les exposés jusqu'à la confirmation de la sérologie négative après la fin de l'allaitement

**si test virologique négatif : refaire le test 6 semaines après la fin de l'allaitement ; si test sérologique positif faire un test virologique le plus tôt possible (voir algorithme de dépistage précoce du VIH)

*** symptômes clés (diarrhée, fièvre, amaigrissement, malnutrition, pneumonie...)

ENSUITE VERIFIER L'ETAT VACCINAL DE L'ENFANT ET LA SUPPLEMENTATION EN VITAMINE A ET LE DEPARASITAGE

CALENDRIER DE VACCINATION :

Période de l'injection	Vaccins	Maladies
Naissance	BCG + VPO 0 + DN HepB	Tuberculose + poliomyélite+ Hépatite
6 semaines (1mois et demi)	DTCHePBHib1 (penta1) + VPO1 + PCV13-1 + Rota 1	
10 semaines (2 mois et demi)	DTCHePBHib 2 (penta2) + VPO2 + PCV13-2 +Rota2	Diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite virale B, poliomyélite, infections à Hib type b, infections à pneumocoque
14 semaines (3 mois et demi)	DTCHePBHib3 (penta3) +VPO3 + PCV13-3 + VPI	Diarrhées à rotavirus
9 mois	RR1+ VAA + Men A	Rougeole, rubéole, fièvre jaune
15 mois	RR2	Rougeole, rubéole

Ne pas perdre de vue la possibilité de MAPI

SUPPLEMENTATION EN VITAMINE A

- Vérifier la date de la première dose
- Donner de la vitamine A à tous les enfants de plus de 6 mois, une fois tous les 6 mois

DEPARASITAGE :

- Donner de l'albendazole ou du Mébendazole à partir de 1 an tous les 6 mois

SI INFECTION SYMPTOMATIQUE PROBABLE

Sont contre indiqués :

- BCG
- Polio oral
- Rota
- RR
- Men A

SI PAS INFECTION SYMPTOMATIQUE

Tous les vaccins du PEV sont recommandés

EVALUER LES AUTRES PROBLEMES ET VERIFIER L'ETAT DE SANTE DE LA MERE

VEILLER A CE QUE L'ENFANT PRESENTANT UN SIGNE QUELCONQUE DE DANGER SOIT REFERE après l'administration de la première dose d'antibiotique approprié et les autres traitements urgents.

Exception : La réhydratation de l'enfant selon le plan C peut éliminer les signes de danger, si bien que la référence n'est plus nécessaire.



TRAITER L'ENFANT

SUIVRE LES ETAPES DE TRAITEMENT INDIQUEES AU TABLEAU EVALUER ET CLASSER



APPRENDRE A LA MERE COMMENT ADMINISTRER DES MEDICAMENTS PAR VOIE ORALE A DOMICILE

Suivre les instructions ci-dessous pour chaque médicament à donner par voie orale à domicile.
Suivre également les instructions du tableau de dosage de chaque médicament.

- Déterminer les médicaments et doses appropriés selon l'âge ou le poids de l'enfant.
- Expliquer à la mère pourquoi l'enfant a besoin du médicament.
- Montrer comment mesurer une dose
- Observer la mère pendant qu'elle mesure une dose
- Demander à la mère de donner la première dose à l'enfant.
- Expliquer en détails comment donner le médicament, puis mettre le médicament dans un sachet ou un cornet et inscrire le nom du médicament sur le sachet ou le cornet.
- Si plusieurs médicaments sont donnés, rassembler, compter et mettre chaque médicament dans un cornet différent.
- Expliquer que tous les médicaments (comprimés ou sirops) doivent être pris jusqu'à la fin du traitement, même si l'enfant se porte mieux.
- S'assurer que la mère a bien compris avant qu'elle ne quitte le dispensaire.

➤ Donner un antibiotique approprié par voie orale

➤ POUR LA PNEUMONIE ou L'INFECTION AIGUE DE L'OREILLE

ANTIBIOTIQUE DE PREMIERE INTENTION : Amoxicilline

ANTIBIOTIQUE DE SECONDE INTENTION : Amoxicilline + acide clavulanique

	AMOXICILLINE Donner trois fois par jour pendant 5 jours			AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE Donner trois fois par jour pendant 5 jours
AGE OU POIDS	Sirop 500 mg par 5 ml	Sirop 250 mg par 5ml	SIROP 125 mg par 5 ml	Sirop 250 mg par 5 ml
De 2 mois à 12 mois (4 à <10kg)	-	2,5 ml (1/2 c à c)	5 ml (1 c à c)	2,5 ml (1/2 c à c)
De 12 mois à 5 ans (10 à 19kg)	2,5 ml (1/2 c à c)	5 ml (1 c à c)	10 ml (2 c à c)	5 ml (1 c à c)

➤ Pour l'INFECTION CHRONIQUE DE L'OREILLE

Le traitement :

1. Assécher l'oreille à l'aide d'une mèche.
2. Si Absence de traitement antibiotique antérieur : Donner l'antibiotique de première intention (Amoxicilline).
3. Si traitement antibiotique antérieur : référer l'enfant.

➤ POUR LA DYSENTERIE

Donner pendant 5 jours l'antibiotique recommandé pour la shigellose dans la région

ANTIBIOTIQUE DE PREMIERE INTENTION POUR LA SHIGELLOSE: Amoxicilline + acide Clavulanique

ANTIBIOTIQUE DE SECONDE INTENTION POUR LA SHIGELLOSE : Ciprofloxacine

	Amoxicilline +Acide Clavulanique Donner 4 fois par jour pendant 5 jours
AGE OU POIDS	Sirop de 250 mg /5ml
De 2 mois à 12 mois (4 à <10kg)	2,5 ml (1/2 c à c)
De 12 mois à 5 ans (10 à 19kg)	5 ml (1 c à c)

	Ciprofloxacine 10 à 15 mg/kg X 2 par jour pendant 5 jours	
POIDS	Ciprofloxacine comprimé 100 mg	Ciprofloxacine comprimé 250 mg
3-<6kg	½ comprimé	¼ comprimé
6<10kg	1 comprimé	½ comprimé
10<15kg	1 comprimé et 1/2	½ comprimé
15<20kg	2 comprimés	1 comprimé

➤ POUR LE CHOLERA

Donner pendant 3 jours l'antibiotique recommandé pour le choléra dans la région.

ANTIBIOTIQUE DE PREMIERE INTENTION POUR LE CHOLERA : Amoxicilline + acide Clavulanique

ANTIBIOTIQUE DE SECONDE INTENTION POUR LE CHOLERA : Tétracycline comprimé 250mg : ½ cpX4/jour (enfant de 6 à 15 kg) ou 1 cpX4/jour (chez les enfants de plus de 15 kg)

APPRENDRE À LA MÈRE COMMENT DONNER LES MÉDICAMENTS PAR VOIE ORALE À DOMICILE

Suivre les instructions ci-dessous pour chaque médicament à donner par voie orale à domicile. Suivre également les instructions du tableau de dosage de chaque médicament

➤ Donner un antipaludique par voie orale

ARTESUNATE + AMODIAQUINE
OU ARTEMETHER + LUMEFANTRINE

➤ ARTESUNATE + AMODIAQUINE ET ARTEMETHER + LUMEFANTRINE :

Expliquer à la mère qu'elle doit surveiller de près son enfant pendant 30 minutes après avoir donné une dose du médicament. Si l'enfant vomit dans les 30 minutes, elle doit redonner la dose et revenir au centre de santé pour obtenir des comprimés supplémentaires.

Age /Poids de l'enfant	Présentation du médicament	1 ^{er} jour	2 ^{ème} jour	3 ^{ème} jour
2-11 mois (4,5-8 kg)	Artésunate (25 mg) + Amodiaquine (67,5 mg)	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé
1-5 ans (9-17 kg)	Artésunate (50 mg) + Amodiaquine (135 mg)	1 comprimé	1 comprimé	1 comprimé

Age /Poids de l'enfant	ARTEMETHER + LUMEFANTRINE COMPRIME 20/120		
	Jour 1	Jour 2	Jour 3
< 1 an (5 – 9 kg)	1 cp.	1 cp.	1 cp.
1-4 ans (10-14 kg)	1 cp. Mat. 1 cp. Soir.	1 cp. Mat. 1 cp. Soir.	1 cp. Mat. 1 cp. Soir.
5-8 ans (15-24 kg)	2 cp. Mat. 2 cp. Soir.	2 cp. Mat. 2 cp. Soir.	2 cp. Mat. 2 cp. Soir.

NB : les comprimés doivent être dilués dans un peu d'eau ou de jus.

Donner du paracétamol ou de l'aspirine pour la fièvre (T°38.5°C ou plus) ou des douleurs d'oreille

➤ Donner le paracétamol toutes les 6 heures jusqu'à ce que la fièvre ou la douleur de l'oreille disparaisse.

ÂGE ou POIDS	Paracétamol				Acide acétyl salicylique	
	Comp 500 mg	Sachet 300 mg	Sachet 80 mg	Sachet 250 mg	Comp 500 mg	Comp 100 mg
de 2 mois à 3 ans (4 à <14 kg)	1/4	-	1	1/2	1/4	1
de 3 ans à 5 ans (14 à <19 kg)	1/2	1	2	1	1/2	1 et 1/2

➤ Donner de la Vitamine A.

- Administrer une dose au centre de santé.

ÂGE	VITAMINE A EN CAPSULES 100 000 UI (Bleu)	VITAMINE A EN CAPSULES 200 000 UI (Rouge)
De la naissance jusqu'à 6 mois		
de 6 mois à 11 mois	1 Capsule	1/2 Capsule
de 12 mois à 59 mois	2 Capsules	1 Capsule

En cas de pneumonie donner une 2^{ème} dose de Vitamine A lors de la visite de suivi.

En cas de rougeole, donner une 2^{ème} dose de vitamine A au 2^{ème} jour, puis 3^{ème} dose 1 mois plus tard.

➤ Donner du fer

- Donner une dose par jour pendant 14 jours.

ÂGE ou POIDS	FER/FOLATE EN COMPRIMÉS	FER EN SIROP Fer fumarate 100 mg par 5 ml (33 mg élément fer par ml)
de 2 mois à 4 mois (4 à <6 kg)		5 ml (1 cuillère à café)
de 4 mois à 12 mois (6 à <10 kg)		7,5 ml (1 cuillère à café et demi)
de 12 mois à 3 ans (10 à <14 kg)	1/2 comprimé	10 ml (2 cuillères à café)
de 3 ans à 5 ans (14 à 19 kg)	1/2 comprimé	12,5 ml (2 cuillères à café et demi)

Si l'enfant est drépanocytaire, donner de l'acide folique : 1 comprimé de 5 mg par jour

➤ DONNER DU MEBENDAZOLE, ALBENDAZOLE ET DES MULTIVITAMINES

AGE	Mébendazole Donner pendant 3 jours			Albendazole Prise unique	Multivitamine	
	Cp 100 mg	Sirop 100 mg	Cp 500 mg	CP 400 mg	Gouttes	Comprimés
A partir de 12 mois	1 cp le matin 1 cp le soir	1 cm le Matin 1 cm le Soir	1/4 cp le matin 1/4 cp le soir	1cp	10/jour	-

CAS PARTICULIERS:

❖ Transfert de nourrissons de moins de 6 mois ou de moins de 3kg

AGE	TRANSFERER A L'UNT
NOURRISSONS : - DE MOINS DE 6 MOIS étant allaités Ou - DE MOINS DE 3 KG étant allaités	➤ Si le nourrisson est trop faible pour téter de façon efficace (quel que soit son P/T, Poids/Âge (P/A) ou autre mesure anthropométrique) OU ➤ Si le nourrisson ne prend pas de poids à domicile (après une série de prise de poids lors du suivi de la croissance, par ex. changement d'indice P/A) OU ➤ Si P/T Z-score < - 3 OU ➤ Si présence d'œdèmes bilatéraux

❖ Dépistage de la malnutrition chronique avec l'indice Taille/Âge

SIGNES (T/A)	CLASSER	TRAITEMENT
Z-score < - 3	Malnutrition chronique sévère	Evaluation nutritionnelle Conseils nutritionnels Suivi de la croissance
- 3 ≤ Z-score < - 2	Malnutrition chronique modérée	
Z-score ≤ - 2	Bon état nutritionnel	Conseil nutritionnel Suivi de la croissance

TRAITER L'ENFANT AYANT UNE INFECTION A VIH

- Dépister et traiter précocement la maladie.
- Surveiller la courbe de poids et encourager la mère à donner fréquemment des aliments hypercaloriques.
- Donner de la vitamine A.
- Donner du cotrimoxazole tous les jours.
- Rechercher et traiter un muguet.
- **Observer le calendrier vaccinal, mais éviter le BCG, Polio oral, Rota, RR et Men A.**
- Revoir l'enfant dans 14 jours, puis tous les mois.

ÂGE ou POIDS	COMPRIMÉ ADULTE 160 mg triméthoprine + 800 mg sulfaméthoxazole	COMPRIMÉ ENFANT 20 mg triméthoprine + 100 mg sulfaméthoxazole
< 5kg)	Non adapté	1
5 - 10 kg	Non adapté	2
10- 20 kg	Non adapté	3
20-35 kg	1/2	4
>35 kg	1	Non adapté

Maintenir cette prophylaxie jusqu'à l'âge de 10 ans quel que soit le stade clinique et le taux de lymphocytes CD4 (Tx CD4).

APPRENDRE À LA MÈRE À TRAITER LES INFECTIONS LOCALES À DOMICILE

- Expliquer à la mère le traitement et pourquoi il doit être donné.
- Décrire les étapes du traitement énumérées dans le cadre approprié.
- Observer la mère pendant qu'elle donne le premier traitement au centre de santé (sauf les remèdes pour la toux ou les douleurs de gorge).
- Expliquer à la mère combien de fois le traitement doit être administré à domicile.
- Si nécessaire pour le traitement à domicile, donner à la mère le tube de pommade tétracycline ou un petit flacon de violet de gentiane.
- S'assurer que la mère a bien compris avant qu'elle ne quitte le Centre de Santé

➤ **Traiter une infection de l'œil avec une pommade ophtalmique antibiotique**

- Nettoyer les yeux, 3 fois par jour :
 - Se laver les mains.
 - Demander à l'enfant de fermer les yeux.
 - Essuyer doucement le pus à l'aide d'un tissu propre et humide.
- Ensuite, appliquer la pommade à la tétracycline dans les yeux, 3 fois par jour :
 - Demander à l'enfant de regarder vers le haut.
 - Appliquer une petite quantité de pommade à l'intérieur de la paupière inférieure.
 - Se laver les mains de nouveau.
- Traiter jusqu'à ce que le pus et la rougeur disparaisse sans dépasser 15 jours.
- Ne pas utiliser d'autres pommades ou collyres et ne rien mettre d'autre dans les yeux.

➤ **Assécher l'oreille à l'aide d'une mèche**

- Assécher l'oreille au moins 3 fois par jour :
 - Rouler en forme de mèche un tissu propre et absorbant ou du papier doux et résistant.
 - Placer la mèche dans l'oreille de l'enfant.
 - Retirer la mèche quand elle est humide.
 - Remplacer la mèche par une autre mèche propre et répéter la procédure jusqu'à ce que la mèche soit sèche.

➤ **Instiller une solution antibiotique dans l'oreille**

Instiller des gouttes de solution Antibiotique (avec ou sans corticoïdes) dans l'oreille malade 1 fois par jour pendant 2 semaines.
Les gouttes contenant des Quinolones sont plus efficaces que les autres.

➤ **Traiter les ulcérations de la bouche au bleu de méthylène**

- Traiter les ulcérations de la bouche 2 fois par jour :
 - Se laver les mains.
 - Nettoyer la bouche de l'enfant avec un tissu propre et doux, roulé autour du doigt et imprégné d'eau salée.
 - Badigeonner la bouche avec du bleu de méthylène
 - Se laver les mains de nouveau
- En cas de muguet ou d'infection à VIH, donner de la nystatine : la nystatine suspension (100 000 unités/ml) : 1 à 2 ml x 4 /J pendant 7 jours

➤ **Calmer la douleur de gorge et la toux avec un remède inoffensif**

- Remèdes inoffensifs recommandés :
 - Lait maternel pour les nourrissons exclusivement allaités.
 - Tisane de Miel au citron : *Dans une demi-tasse d'eau tiède, mettre deux cuillères à café de miel et le jus d'un demi-citron vert. Donner cette tisane à boire à l'enfant au moins 3 fois par jour.*
- Remèdes dangereux à déconseiller :
 - Tous les sirops antitussifs du commerce

Arrêter les convulsions avec du diazépam

➤ **Dégager les voies respiratoires**

- Placer l'enfant sur le côté
 - Ne rien mettre dans la bouche
 - Si les lèvres et la langue sont bleuâtres, ouvrir la bouche pour s'assurer que les voies respiratoires sont libres
- Si besoin, aspirer les sécrétions de la gorge avec une sonde introduite par la narine (à défaut utiliser une poire)

➤ **Administer le diazépam par voie rectale**

- Aspirer la quantité de diazépam nécessaire dans une seringue
- Rajouter 1 à 2 ml d'eau
- Retirer l'aiguille de la seringue
- Insérer la seringue à 1 ou 2 cm dans le rectum et injecter la solution de diazépam
- Tenir les fesses serrées pendant quelques minutes

AGE OU POIDS	DIAZEPAM ADMINISTRE PAR VOIE RECTALE Solution de 10 mg/2ml Dose : 0,5 mg/kg
De 1 à 4 mois (3 à <6 kg)	0,5 ml
De 4 à 12 mois (6 à <10 kg)	1 ml
De 12 mois à 3 ans (10 à <14 kg)	1,25 ml
De 3 ans à 5 ans (14 à 19 kg)	1,5 ml

Traiter l'enfant pour éviter l'hypoglycémie

➤ **Si l'enfant est capable de prendre le sein:**

- Demander à la mère d'allaiter l'enfant

➤ **Si l'enfant est incapable de prendre le sein mais est capable d'avalier:**

- Donner du lait exprimé ou un lait de remplacement.
- Donner de l'eau sucrée si ni l'un ni l'autre n'est disponible

Quantité à donner : 30 - 50 ml de lait ou d'eau sucrée avant le départ

Pour faire de l'eau sucrée, dissoudre 4 carreaux de sucre (20 grammes) dans une tasse de 200 ml d'eau propre

➤ **Si l'enfant est incapable d'avalier:**

- Donner 50 ml de lait ou d'eau sucrée par sonde nasogastrique

Faire baisser la température en cas de fièvre

- **Mesures physiques** : Faire un enveloppement humide ; Il faut envelopper l'enfant qui a le corps très chaud (forte fièvre) dans une serviette ou un pagné trempé dans l'eau. Recommencer l'enveloppement humide jusqu'à ce que la fièvre baisse
- **Médicaments** : Paracétamol ou AAS

POUR LA DIARRHÉE, DONNER LE ZINC, PLUS DE LIQUIDES ET CONTINUER L'ALIMENTATION

(Voir conseils sur l'ALIMENTATION au tableau CONSEILLER LA MÈRE)

➤ Plan A: Traiter la diarrhée à domicile

Apprendre à la mère les 4 règles du traitement à domicile:
Donner davantage de liquides, continuer l'alimentation, et quand revenir

1. DONNER DAVANTAGE DE LIQUIDES (autant que l'enfant veut bien prendre)

➤ EXPLIQUER À LA MÈRE:

- Qu'il faut allaiter plus fréquemment et prolonger la durée de la tétée.
- Que si l'enfant est nourri uniquement au sein, il faut lui donner une solution de SRO ou de l'eau propre en plus du lait maternel.
- Que si l'enfant n'est pas nourri uniquement au sein, il faut lui donner une ou plusieurs fois: solution de SRO, aliments liquides [lait caillé, yaourt liquide, eau de riz (bouillie de riz), soupe, jus de coco frais, koko (bouillie de mil), ou eau propre, etc.....

Il est crucial de donner une solution de SRO à domicile si:

- l'enfant était sous traitement par plan B ou C pendant la visite.
- l'enfant ne peut pas être ramené au centre de santé si la diarrhée s'aggrave.

➤ APPRENDRE À LA MÈRE COMMENT MÉLANGER ET ADMINISTRER LA SOLUTION SRO. DONNER À LA MÈRE 2 PAQUETS DE SOLUTION SRO À UTILISER À DOMICILE.

➤ MONTRER À LA MÈRE QUELLE QUANTITÉ DE LIQUIDE ELLE DOIT DONNER EN PLUS DE LA CONSOMMATION NORMALE:

Jusqu'à 2 ans, 50 à 100 ml après chaque selle liquide soit 1/2 à 1 louche moyenne
2 ans et plus, 100 à 200 ml après chaque selle liquide soit 1 à 2 louches moyennes

*100 ml = une louche en moyenne

Expliquer à la mère qu'il faut:

- Donner fréquemment à boire dans une tasse, par petites gorgées.
- Si l'enfant vomit, attendre 10 minutes. Puis continuer, mais plus lentement.
- Continuer à donner davantage de liquides jusqu'à l'arrêt de la diarrhée.

2. DONNER DU ZINC (comprimé 20 mg) Dissoudre le comprimé dans un peu de lait maternel, de SRO ou d'eau propre, dans une tasse ou une cuillère

≤ 6 mois	1/2 comprimé par jour pendant 10 -14 jours
> 6 mois	1 comprimé par jour pendant 10 -14 jours

3. CONTINUER L'ALIMENTATION

4. QUAND REVENIR

} Voir tableau CONSEILLER LA MÈRE

➤ Plan B: Traiter les signes évidents de déshydratation avec une solution de SRO

Administrer, au centre de santé et sur une période de 4 heures, la quantité de solution de SRO recommandée

➤ DÉTERMINER LA QUANTITÉ DE SRO À ADMINISTRER PENDANT LES 4 PREMIÈRES HEURES.

* N'utiliser l'âge de l'enfant que si son poids n'est pas connu. La quantité approximative de solution de SRO nécessaire (en ml) peut aussi être calculée en multipliant le poids de l'enfant (en kg) par 75.

ÂGE*	Jusqu'à 4 mois	4 mois à 12 mois	12 mois à 2 ans	2 ans à 5 ans
POIDS	< 5 kg	6 - < 10 kg	10 - < 12 kg	12 - 19 kg
Quantité de SRO en ml	200 - 400	400 - 700	700 - 900	900 - 1400

- Si l'enfant veut davantage de solution de SRO, lui en donner plus.
- Pour les enfants de moins de 6 mois qui ne sont pas nourris au sein, donner également 100 à 200 ml d'eau propre pendant cette période.

➤ MONTRER À LA MÈRE COMMENT DONNER LA SOLUTION DE SRO.

- Faire boire fréquemment l'enfant à la tasse, par petites gorgées.
- Si l'enfant vomit, attendre 10 minutes. Puis continuer, mais plus lentement.
- Vérifier la prise de SRO
- Continuer à allaiter fréquemment

➤ APRÈS 4 HEURES:

- Réexaminer l'enfant et classer la déshydratation.
- Choisir le plan approprié pour continuer le traitement.
- Commencer à alimenter l'enfant au centre de santé.

➤ SI LA MÈRE DOIT PARTIR AVANT LA FIN DU TRAITEMENT:

- Lui montrer comment préparer la solution de SRO à domicile.
- Lui montrer combien de SRO elle doit donner pour finir le traitement de 4 heures à domicile.
- Lui donner assez de paquets de SRO pour terminer le traitement de réhydratation du plan B. Lui donner également 2 paquets, comme recommandé dans le Plan A.
- Expliquer les 4 règles du traitement à domicile:

1. DONNER DAVANTAGE DE LIQUIDE

2. DONNER DU ZINC

3. CONTINUER L'ALIMENTATION

4. QUAND REVENIR

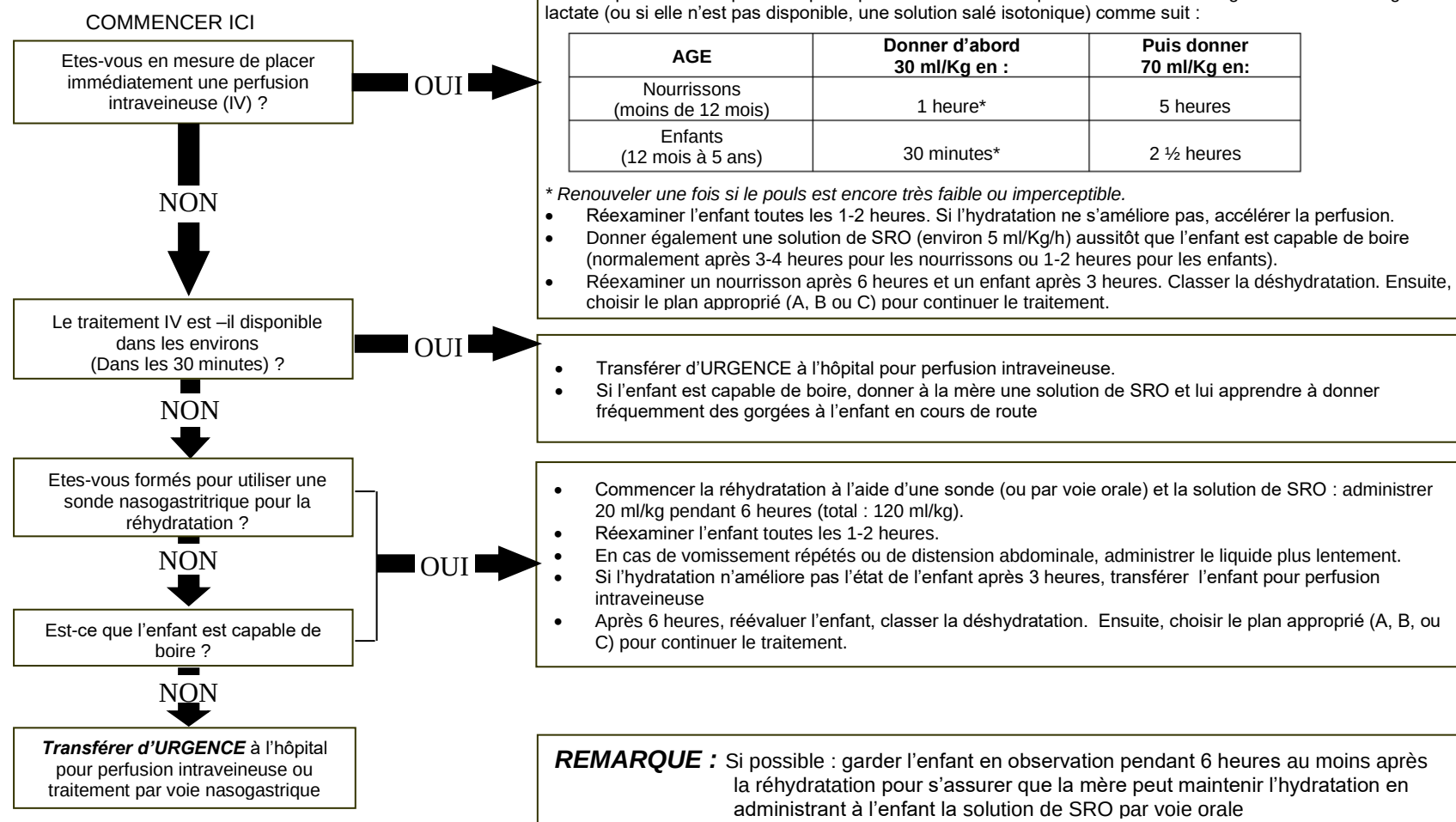
} Voir Plan A pour les liquides recommandés et Voir tableau CONSEILLER LA MÈRE

POUR LA DIARRHÉE, DONNER PLUS DE LIQUIDES ET CONTINUER L'ALIMENTATION

(Voir conseils sur l'ALIMENTATION au tableau CONSEILLER LA MÈRE)

Plan C : Traiter rapidement la déshydratation sévère

- SUIVRE LES FLECHES. SI LA RÉPONSE EST « OUI » FAIRE CE QUI EST INDiqué À DROITE. SI LA RÉPONSE EST « NON » PASSER À LA QUESTION SUIVANTE :



SUIVI DES SOINS

- Soigner l'enfant ramené au centre de santé pour une visite de suivi, en utilisant tous les cadres qui correspondent aux classifications précédentes de l'enfant.
- Si l'enfant présente un nouveau problème, évaluer, classer et traiter le nouveau problème comme indiqué au tableau **EVALUER ET CLASSER**

SUIVI DES SOINS

- Soigner l'enfant ramené au centre de santé pour une visite de suivi, en utilisant tous les cadres qui correspondent aux classifications précédentes de l'enfant.

➤ PALUDISME

Si la fièvre persiste après 3 jours

Refaire une évaluation complète de l'enfant.
Rechercher d'autres causes de fièvre.

} Voir le tableau *EVALUER & CLASSER*

Traitement:

- Si la prise du traitement est incorrecte : reprendre le traitement initial
- En l'absence de signes d'autres maladies : faire le traitement de deuxième intention (quinine par voie orale)
- Si l'enfant présente **un signe général de danger**, ou un signe de paludisme grave traiter comme PALUDISME GRAVE OU MALADIE FEBRILE TRÈS GRAVE.
- Si l'enfant présente **une cause de fièvre autre que le paludisme**, donner le traitement qui convient.
- Si **le paludisme est la seule cause apparente de la fièvre**:
 - Administrer la première dose d'artémisinine 50 mg en suppositoire et Référer
 - Si impossible de référer.
 - Traiter avec Artéméther injectable pendant 5 jours
 - Si ce produit n'est pas disponible, transférer l'enfant à l'hôpital.

➤ ROUGEOLE AVEC COMPLICATIONS AUX YEUX OU À LA BOUCHE

Après 2 jours:

Regarder si les yeux sont rouges et s'il y a écoulement de pus.
Regarder s'il y a des ulcérations dans la bouche.
Sentir l'odeur de la bouche (à la première consultation).

Traitement de l'infection de l'œil:

- Si **du pus s'écoule encore des yeux**, demander à la mère de décrire comment elle a traité l'infection de l'œil. Si le traitement était correct, transférer l'enfant à l'hôpital. Si le traitement était incorrect, apprendre à la mère à traiter correctement.
- Si **le pus a disparu mais les yeux sont encore rouges**, continuer le traitement.
- S'il **n'y a plus de pus ni de rougeur**, continuer le traitement jusqu'à son terme.

Traitement des ulcérations dans la bouche:

- Si **les ulcérations se sont aggravées ou si la bouche dégage une très mauvaise odeur**, transférer l'enfant à l'hôpital.
- Si **les ulcérations sont identiques ou se sont améliorées**, continuer le traitement au bleu de méthylène pendant 5 jours.

SUIVI DES SOINS

- Soigner l'enfant ramené au centre de santé pour une visite de suivi, en utilisant tous les cadres qui correspondent aux classifications précédentes de l'enfant.
- Si l'enfant présente un nouveau problème, évaluer, classer et traiter le nouveau problème comme indiqué au tableau EVALUER ET CLASSER

➤ INFECTION DE L'OREILLE

Après 5 jours :

Réévaluer le problème d'oreille.
Prendre la température de l'enfant.

Voir tableau EVALUER & CLASSER

Traitement:

- S'il y a **gonflement douloureux derrière l'oreille ou si la fièvre est élevée (39° C ou plus)**, transférer d'URGENCE au centre de référence.
- **Infection aiguë de l'oreille : si la douleur de l'oreille ou l'écoulement** persiste, traiter pendant 5 jours supplémentaires avec le même antibiotique. Continuer à assécher l'oreille. revoir dans 5 jours.
- **Infection chronique de l'oreille** : vérifier si la mère assèche l'oreille correctement. L'encourager à continuer.
- Si **l'oreille n'est pas douloureuse et ne coule pas** féliciter la mère pour le traitement correct. Si elle n'a pas fini le traitement antibiotique de 5 jours, lui dire de continuer le traitement jusqu'à la fin.

➤ PROBLEME D'ALIMENTATION

Après 7 jours :

Réévaluer l'alimentation. Voir questions en haut du tableau CONSEILLER LA MERE.
Poser des questions sur les problèmes d'alimentation notés lors de la première visite.

- Conseiller la mère sur tout nouveau problème ou problème persistant d'alimentation. s'il est conseillé à la mère de modifier l'alimentation, lui conseiller de revenir pour une visite de suivi.

➤ ANEMIE

Après 14 jours :

- Donner du fer pour les 14 prochains jours.
- Conseiller à la mère de revenir chercher du fer dans 14 jours.
- Continuer à approvisionner la mère en fer tous les 14 jours pendant 2 mois
- Si la pâleur palmaire est encore présente chez l'enfant après 2 mois transférer pour bilan
- Pour l'enfant drépanocytaire, donner l'acide folique à la place du fer.

➤ MALNUTRITION MODEREE

Après 14 jours :

Peser l'enfant et déterminer si le poids de l'enfant est encore faible pour son âge.
Mesurer l'enfant et déterminer si le poids de l'enfant est faible pour sa taille.
Réévaluer l'alimentation. Voir questions en haut du tableau CONSEILLER LA MERE.

Traitement :

- Si le poids de l'enfant **augmente**, féliciter la mère et l'encourager à continuer.
- Si le poids de l'enfant est encore **faible pour son âge et/ou pour sa taille**, conseiller la mère sur les problèmes d'alimentation identifiés. Demander à la mère de revenir dans 14 jours. Continuer de voir l'enfant toutes les 2 semaines jusqu'à ce que son poids ne soit plus faible pour son âge et/ou pour sa taille.

NB : Si l'enfant a **perdu du poids** transférez-le à l'UNTA.

SI D'AUTRES VISITES DE SUIVI SONT NECESSAIRES EN FONCTION DE LA PREMIERE VISITE OU DE CETTE VISITE, CONSEILLER A LA MERE DE REVENIR POUR LA PROCHAINE VISITE DE SUIVI.

EN OUTRE, EXPLIQUER A LA MERE QUAND REVENIR IMMEDIATEMENT. (Voir tableau CONSEILLER LA MERE)

INFECTION A VIH

PREMIER SUIVI

- Vérifier que l'enfant a eu un test VIH et que le résultat a été donné. S'assurer que la mère a reçu les conseils post test appropriés

SI LE TEST EST POSITIF :

- Débuter le traitement ARV et expliquer à la mère l'importance de poursuivre le traitement
- Poursuivre l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, débiter l'alimentation de complément dès 6 mois tout en maintenant l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans
- Evaluer l'état général de l'enfant. Faire une évaluation totale (voir évaluer et classer)
- Faire une recherche active de la tuberculose
- Traiter l'enfant pour toutes les affections retrouvées
- Rechercher un muguet ou des ulcérations buccales
- Rechercher tout nouveau problème d'alimentation. Conseiller la mère sur tout problème nouveau ou ancien
- Peser l'enfant et en tenir compte s'il y a une cassure de la courbe de poids, malgré une alimentation correcte
- Vérifier la supplémentation en vitamine A. Donner de la vitamine A, si l'enfant n'en a pas reçu les 6 mois précédents
- Conseiller à la mère de ramener l'enfant, si un nouveau problème apparaît ou si elle est inquiète
- Revoir l'enfant dans un mois
- Débuter la prophylaxie avec le cotrimoxazole pour prévenir la pneumocystose. Expliquer à la mère l'importance de poursuivre le traitement
- Conseiller la mère sur tout autre problème et s'assurer qu'un soutien communautaire est apporté. Référer pour des conseils ultérieurs si nécessaire
- Revoir l'enfant tous les mois après la première visite.

SI LE TEST EST NEGATIF :

- Conseiller la mère sur tout autre problème
- Poursuivre l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, débiter l'alimentation de complément dès 6 mois tout en maintenant l'allaitement jusqu'à l'âge de 1 ans
A partir de 6 mois de vie si la mère décide d'arrêter l'allaitement s'assurer que les conditions AFADS sont réunies
 - L'arrêt de l'allaitement doit être progressif par la réduction du nombre de tétées qui sont remplacées par du lait 2^{ème} âge donné à la tasse.
 - Introduire l'alimentation de complément.
- Refaire le test sérologique VIH 6 semaines après l'arrêt de l'allaitement
- Revoir l'enfant selon son problème actuel (VOIR TABLEAU EVALUER ET CLASSER)

REPETER LE SUIVI

- Evaluer l'état général de l'enfant. Faire une évaluation totale (VOIR EVALUER ET CLASSER)
- Traiter l'enfant pour toutes les affections retrouvées
- Rechercher un muguet ou des ulcérations buccales
- Rechercher tout nouveau problème d'alimentation. Conseiller la mère sur tout problème nouveau ou ancien
- Rechercher le poids de l'enfant et s'y référer s'il y a une cassure de la courbe de poids, malgré une alimentation correcte
- Vérifier la supplémentation en vitamine A. Donner de la vitamine A, si l'enfant n'en a pas reçu les 6 mois précédents
- Conseiller à la mère de ramener l'enfant, si un nouveau problème apparaît ou si elle est inquiète
- Donner à nouveau du cotrimoxazole. Expliquer à la mère l'importance de poursuivre le traitement
- Conseiller la mère sur tout autre problème et s'assurer qu'un soutien communautaire est apporté. Référer pour des conseils ultérieurs si nécessaire
- Suivre l'enfant tous les mois.

CONSEILLER LA MERE

LES ALIMENTS

➤ ***Evaluer l'alimentation de l'enfant***

Poser des questions sur l'alimentation habituelle de l'enfant et sur son alimentation durant cette maladie. Comparer les réponses de la mère aux **Recommandations pour l'alimentation** selon l'âge de l'enfant dans le cadre ci-dessous.

DEMANDER :

➤ Allaiter-vous l'enfant?

Combien de fois pendant la journée?

L'allaiter-vous aussi pendant la nuit?

➤ Est-ce que l'enfant consomme d'autres aliments ou liquides?

Quels aliments ou liquides?

Combien de fois par jour?

Comment donnez-vous à manger à l'enfant?

Si le poids de l'enfant est faible pour son âge et/ ou pour sa taille: Quelle quantité lui donnez-vous à chaque repas? L'enfant reçoit-il sa propre part? Qui nourrit l'enfant et comment est-il nourrit?

➤ Pendant cette maladie, les habitudes alimentaires de l'enfant ont-elles changé? Si oui, comment? Pourquoi ?

➤ Recommandations pour l'alimentation (pour l'enfant malade et l'enfant en bonne santé)

De la naissance à 6 mois



- **Commencer l'allaitement dans l'heure qui suit l'accouchement. Ne rien donner d'autre en dehors du sein de la mère**

Allaiter aussi souvent que l'enfant réclame, jour et nuit, au moins 8 fois en 24 heures

De 6 mois à 9 mois



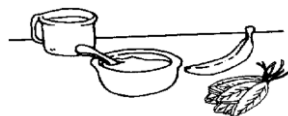
- Continuer à allaiter à la demande nuit et jour, au moins 8 fois par 24 heures

En plus :

- Donner 2 bouillies épaisses de céréales enrichies au lait ou farine de soja ou à la pâte d'arachide, à l'huile ou au beurre de karité, au jaune d'œuf (à partir de 7 mois)

Et à partir de 7 mois donner une purée faite de l'igname, patate douce, taro, banane plantain, pomme de terre, courge... sous forme de purée enrichie à l'huile ou au beurre de karité.

- Donner 2 goûters : yaourt, jaune d'œuf (à partir de 7 mois), galette, pain garni, fruit de saison etc.



De 9 mois à 2 ans



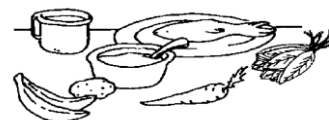
- Continuer à allaiter à la demande nuit et jour, au moins 8 fois par 24 heures

En plus :

- Donner 1 bouillie épaisse de céréales enrichies au lait, à la farine de soja ou à la pâte d'arachide, à l'huile ou au beurre de karité, au jaune d'œuf, à l'huile, à l'œuf, à la pâte d'arachide ou au beurre de karité ;

OU bien d'autres aliments tels que l'igname, patate douce, taro, banane plantain, pomme de terre, courge en morceaux

- Donner en plus 2 repas de famille sans épice
- Donner 2 goûters : yaourt, œuf dur, galette, pain garni, fruit de saison etc.



2 ans et plus



- Donner en plus 3 repas de famille sans épice.

- Donner 2 goûters : yaourt, œuf dur, galette, pain garni, fruit de saison etc.



Recommandations pour l'alimentation d'un enfant avec une DIARRHÉE PERSISTANTE

- S'il est encore nourri au sein, l'allaiter plus fréquemment et plus longtemps, jour et nuit.
- Si l'enfant consomme un autre lait:
 - remplacer ce lait en augmentant les tétées **OU**
 - remplacer ce lait par des produits laitiers fermentés, tels que le lait caillé **OU**
 - remplacer la moitié de ce lait par des aliments épais très nutritifs.
- Pour les autres aliments, suivre les recommandations pour l'alimentation de l'enfant selon son âge.

RECOMMANDATION POUR L'ALIMENTATION DE L'ENFANT NE DE MERE INFECTEE PAR LE VIH

Conseiller la mère sur le choix du type d'alimentation de son enfant
Soutenir la mère dans son choix

2 options :

- Allaitement exclusif jusqu'à 6 mois puis alimentation de complément à partir de 6 mois tout en poursuivant l'allaitement jusqu'à 24 mois.
- Alimentation de remplacement dès la naissance jusqu'à 6 mois (si conditions AFADS réunies), suivi de l'alimentation de complément) AFADS ; ACCEPTABLE, FAISABLE, ABORDABLE, DURABLE ET SURE



Conseils sur les problèmes d'alimentation

Si l'enfant n'est pas nourri comme indiqué ci-dessus, conseiller la mère en conséquence. En outre:



- Si la mère signale qu'elle a des difficultés à allaiter, évaluer l'allaitement. (Voir tableau *EVALUER, CLASSER ET TRAITER LE NOURRISSON*). Si nécessaire, montrer à la mère le bon positionnement pour l'allaitement et la bonne prise du sein
- Si l'enfant a moins de 6 mois et consomme un autre lait, d'autres aliments ou de l'eau:

- Renforcer la confiance de la mère en lui assurant qu'elle peut produire tout le lait dont l'enfant a besoin.
- Suggérer de mettre l'enfant au sein plus fréquemment, de l'y laisser plus longtemps, le jour comme la nuit, et de réduire progressivement l'autre lait ou les aliments ou l'eau.

Si la consommation d'un autre lait doit continuer, conseiller à la mère:

- D'allaiter autant que possible, surtout la nuit.
- De s'assurer que l'autre lait est un lait de substitution localement préparé.
- De s'assurer que l'autre lait est préparé correctement, hygiéniquement et est donné en quantité adéquate.
- De finir, dans l'heure, le lait préparé.



- Si la mère nourrit l'enfant au biberon:

- Conseiller de remplacer le biberon par une tasse.
- Montrer à la mère comment utiliser une tasse pour nourrir son enfant.

- Si l'enfant se nourrit mal, conseiller à la mère:

- De s'asseoir avec l'enfant et de l'encourager à manger.
- De donner à l'enfant une ration adéquate dans une assiette ou dans un bol séparé.



- Si l'enfant se nourrit mal pendant une maladie, conseiller à la mère:

- D'allaiter plus fréquemment et plus longtemps, si possible.
- D'offrir des aliments faciles à manger, variés, appétissants et préférés par l'enfant pour l'encourager à manger le plus possible, et lui donner de fréquents petits repas.
- De désobstruer le nez de l'enfant si son nez bouché l'empêche de manger.
- Dire à la mère que l'appétit sera meilleur quand l'enfant ira mieux.

- Revoir tout problème d'alimentation dans 7 jours.

RECOMMANDATIONS POUR L'ALIMENTATION
PROBLÈMES D'ALIMENTATION

LES LIQUIDES

➤ Conseiller à la mère d'augmenter la consommation de liquides pendant toute la maladie

POUR TOUT ENFANT MALADE:

- Allaiter plus fréquemment et pendant plus longtemps.
- Augmenter les liquides. Par exemple, donner de la bouillie de céréales, de l'eau propre, du lait caillé, du yaourt.

POUR L'ENFANT DIARRHÉIQUE:

- L'administration des liquides supplémentaires peut sauver la vie de l'enfant diarrhéique. Administrer les liquides selon le Plan A ou le Plan B du tableau *TRAITER L'ENFANT*

QUAND REVENIR

➤ Expliquer à la mère quand revenir au centre de santé

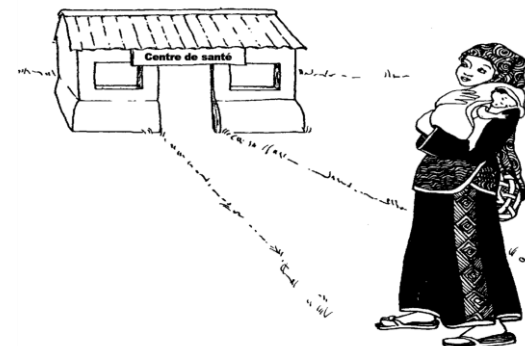
➤ VISITE DE SUIVI

Demander à la mère de revenir pour une visite de suivi dans le plus court des délais mentionnés pour les problèmes de l'enfant.

Si l'enfant a:	Revenir pour une visite de suivi dans:
PNEUMONIE SIGNES ÉVIDENTS DE DÉSHYDRATATION PAS DE DÉSHYDRATATION DYSENTERIE PALUDISME ROUGEOLE AVEC COMPLICATIONS AUX YEUX ET/OU À LA BOUCHE	2 jours
DIARRHÉE PERSISTANTE INFECTION AIGUË DE L'OREILLE INFECTION CHRONIQUE DE L'OREILLE PROBLÈME D'ALIMENTATION AUTRE MALADIE, s'il n'y a pas d'amélioration	5 jours
MALNUTRITION SEVERE SANS COMPLICATION	7 jours
ANEMIE INFECTION SYMPTOMATIQUE PROBABLE VIH MALNUTRITION MODERÉE	14 jours

➤ PROCHAINE VISITE SYSTEMATIQUE

Expliquer à la mère quand revenir pour la prochaine vaccination selon le calendrier vaccinal, la supplémentation en vit A et le déparasitage.



QUAND REVENIR IMMÉDIATEMENT

Conseiller à la mère de revenir immédiatement si l'enfant présente l'un des signes suivants:

Tout enfant malade qui:	• Est incapable de boire ou de téter • Devient plus malade • A de la fièvre
Si l'enfant est classé PAS DE PNEUMONIE: TOUX OU RHUME, revenir également si:	• La respiration est rapide • La respiration est difficile
Si l'enfant a la diarrhée, revenir également si:	• Les selles contiennent du sang • L'enfant boit difficilement

➤ ***Donner des conseils à la mère sur sa propre santé***

- Si la mère est malade, la soigner ou la référer pour assistance
- Si elle a un problème aux seins (tel que engorgement, crevasse du mamelon, infection du sein), la soigner ou la référer pour traitement
- Lui conseiller de bien se nourrir pour entretenir sa force et sa santé
- Vérifier l'état vaccinal de la mère et lui faire une piqûre antitétanique, si nécessaire
- S'assurer qu'elle a accès:
 - au planning familial
 - aux conseils sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du sida
- S'informer sur l'état de santé des autres enfants et conseiller sur l'état vaccinal, l'alimentation, l'hygiène corporelle, la croissance

EVALUER, CLASSER ET TRAITER LE NOURRISSON MALADE

AGE DE 1 SEMAINE A 2 MOIS

EVALUER

DEMANDER A LA MERE QUELS SONT LES PROBLEMES DU NOURRISSON

- Rechercher le motif de consultation
 - Déterminer s'il s'agit d'un épisode initial ou d'un épisode répété
 - Déterminer s'il s'agit d'une première visite ou d'une visite de suivi pour cet épisode.
- S'il s'agit d'une visite de suivi, utiliser les instructions de suivi décrites en bas du tableau TRAITER L'ENFANT.
S'il s'agit d'une première visite, évaluer l'enfant comme suit :*

CLASSER

POUR CLASSER LA MALADIE, UTILISER TOUS LES CADRES QUI CORRESPONDENT AUX SYMPTOMES ET PROBLÈMES DU NOURRISSON

IDENTIFIER LE TRAITEMENT

Rechercher les infections bactériennes possibles

SIGNES

CLASSER

TRAITEMENT

(Les traitements urgents pré-évacuation sont en caractères gras et en italique)

DEMANDER

- Le nourrisson a-t-il eu des convulsions?

DEMANDER ET OBSERVER

- ATCD de ou difficultés à s'alimenter

OBSERVER, ÉCOUTER, PALPER:

- Regarder si le nourrisson convulse actuellement
- Compter les mouvements respirations par minute. Recommencer si le nombre est > ou = 60
- Rechercher un tirage sous-costal marqué.
- Regarder et écouter un geignement expiratoire
- Prendre la température (le nourrisson a-t-il de la fièvre)
- Prendre la température (le nourrisson est-il hypothermique).
- Regarder si le nourrisson bouge seulement s'il est stimulé

L'ENFANT DOIT ÊTRE CALME

Classer TOUS LES NOURRISSONS

- Convulsions (actuelles ou non) OU
- ATCD de ou difficultés à se nourrir OU
- Respiration rapide (60 mouvements respiratoires par minute OU plus) OU
- Tirage sous-costal marqué OU
- Geignement OU
- Hyperthermie (38°C* ou plus) OU
- Hypothermie (en dessous de 36°C*) OU
- Bouge seulement si stimulé

POSSIBILITÉ D'INFECTION BACTÉRIENNE GRAVE

- *Si l'enfant convulse actuellement, donner des anticonvulsivants*
- *Donner la première dose d'antibiotique appropriée en intramusculaire.*
- *Traiter pour éviter l'hypoglycémie.*
- *Expliquer à la mère comment veiller à ce que le nourrisson n'ait pas froid sur le chemin de l'hôpital.*
- *Transférer d'URGENCE à l'hôpital.***

- Omphalite rouge ou suintant de pus
- Pustules cutanées

INFECTION BACTÉRIENNE LOCALE

- *Donner un antibiotique approprié par voie orale.*
- *Apprendre à la mère à traiter les infections locales à domicile.*
- *Expliquer à la mère comment soigner le nourrisson à domicile.*
- *Revoir après 2 jours.*

- Aucun des signes précédents n'est retrouvé

PAS D'INFECTION

- Expliquer à la mère comment prendre soin du nourrisson.
- Revoir dans 2 jours.

Si le transfert n'est pas possible, voir Prise en charge des maladies de l'enfant Annexe: Lorsque le transfert n'est pas possible

PUIS DEMANDER: Le nourrisson a-t-il la diarrhée?

SI OUI, DEMANDER:

- Depuis combien de temps?
- Y a-t-il du sang dans les selles?

OBSERVER ET PALPER:

- Observer l'état général du nourrisson. Est-il:
Léthargique ou inconscient?
Agité ou irritable?
- Regarder si les yeux sont enfoncés.
- Pincer la peau de l'abdomen.
Le pli cutané s'efface-t-il:
-Très lentement (plus de 2 secondes) ?
-Lentement ?

En cas de diarrhée persistante ou récidivante, évaluer l'enfant pour infection symptomatique VIH

*pour la
DÉSHYDRATATION*

**Classer la
DIARRHÉE**

*et si la diarrhée
persiste depuis
14 jours ou plus*

*et s'il y a du sang
dans les selles*

SIGNES

CLASSER

TRAITEMENT

(le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)

Deux des signes suivants:

- Léthargique ou inconscient
- Yeux enfoncés
- Pli cutané s'efface très lentement.

**DÉSHYDRATATION
SÉVÈRE**

- Si le nourrisson n'est pas classé POSSIBILITÉ D'INFECTION BACTÉRIENNE GRAVE
- Donner des liquides pour déshydratation sévère (Plan C) **OU**
- **Si le nourrisson est aussi classé POSSIBILITÉ D'INFECTION BACTÉRIENNE GRAVE:**
- **Transférer d'URGENCE au centre de référence, la mère donnant fréquemment des gorgées de SRO en cours de route.**
- **Conseiller à la mère de continuer l'allaitement**

(le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)

Deux des signes suivants:

- Agité, irritable
- Yeux enfoncés
- Pli cutané s'efface lentement.

**SIGNES ÉVIDENTS
DE
DÉSHYDRATATION**

- Donner des liquides et des aliments pour signes évidents de déshydratation (Plan B).
- **Si le nourrisson est aussi classé POSSIBILITÉ D'INFECTION BACTÉRIENNE GRAVE:**
- **Transférer d'URGENCE au centre de référence, la mère donnant fréquemment des gorgées de SRO en cours de route.**
- **Conseiller la mère de continuer l'allaitement au sein.**

- Pas assez de signes pour classer comme signes évidents de déshydratation ou déshydratation sévère.

**PAS DE
DÉSHYDRATATION**

- Donner des liquides pour traiter la diarrhée à domicile (Plan A)

- Diarrhée depuis 14 jours ou plus.

**DIARRHÉE
PERSISTANTE
GRAVE**

- Si le nourrisson est déshydraté, traiter la déshydratation avant le transfert, sauf s'il est aussi classé POSSIBILITÉ D'INFECTION BACTÉRIENNE GRAVE.
- Transférer au centre de référence

- Sang dans les selles.

**SANG DANS LES
SELLES**

- **Traiter le nourrisson pour éviter l'hypoglycémie.**
- **Conseiller à la mère de garder le nourrisson au chaud**
- **Transférer d'urgence au centre de référence**

PUIS RECHERCHER LES PROBLÈMES D'ALIMENTATION OU D'INSUFFISANCE PONDÉRALE:

DEMANDER:	OBSERVER:	Classer l'ALIMENTATION	SIGNES	CLASSE	TRAITEMENT (le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)
- Le nourrisson a-t-il des difficultés à se nourrir? - Le nourrisson est-il nourri au sein? Si oui, combien de fois en 24 heures? - Le nourrisson reçoit-il d'habitude d'autres aliments ou d'autres boissons? Si oui, combien de fois? - Comment donnez-vous à manger au nourrisson?	- Déterminer le poids pour l'âge - Déterminer le poids pour la taille		- Mauvaise prise du sein, OU - Succion non efficace, OU - Moins de 8 tétées en 24 heures, OU - Reçoit d'autres aliments ou liquides, OU - Poids faible pour l'âge et/ou pour la taille, OU - Muguet (ulcérations ou plaques blanches dans la bouche).	PROBLÈME D'ALIMENTATION OU POIDS FAIBLE POUR L'ÂGE ET/OU POUR LA TAILLE	➢ Conseiller à la mère d'allaiter le nourrisson aussi souvent et aussi longtemps que le nourrisson réclame, jour et nuit. • Si la prise du sein est mauvaise ou si la succion n'est pas efficace, expliquer la bonne position et la bonne prise du sein. • Si la mère allaite moins de 8 fois en 24 heures, lui conseiller d'allaiter plus souvent. ➢ . • Si pas d'allaitement: - Référer pour conseils sur l'allaitement et éventuellement la relactation. - Apprendre à la mère à préparer correctement un substitut au lait maternel et à utiliser une tasse. ➢ En cas de muguet, apprendre à la mère à le traiter à domicile. ➢ Conseiller la mère sur les soins à domicile ➢ Revoir tout problème d'alimentation ou de muguet après 2 jours. Revoir tout problème de poids faible pour l'âge après 14 jours.
SI UN NOURRISSON: A des difficultés à se nourrir, ou Est allaité moins de 8 fois en 24 heures, ou Consomme d'autres aliments ou d'autres liquides, ou Est de poids faible pour son âge et/ou pour sa taille, ET Ne présente aucun signe justifiant le transfert d'urgence à l'hôpital: EVALUER L'ALLAITEMENT: - Le nourrisson a-t-il été nourri au sein durant l'heure précédente? Si le nourrisson n'a pas été allaité durant l'heure précédente, demander à la mère de mettre le nourrisson au sein. Observer l'allaitement pendant 4 minutes (Si le nourrisson a été allaité durant l'heure précédente, demander à la mère si elle peut attendre et vous dire quand le nourrisson réclamera le sein de nouveau.) - Le nourrisson peut-il bien prendre le sein? <i>Pas de prise de sein - Mauvaise prise de sein - Bonne prise de sein</i> POUR VÉRIFIER LA PRISE DU SEIN, REGARDER SI: - Le menton touche le sein - La bouche est grande ouverte - La lèvre inférieure est éversée vers l'extérieur - L'aréole est plus visible au-dessus qu'au-dessous de la bouche (Tous ces signes doivent être présents pour que la prise du sein soit bonne) - Est-ce que le nourrisson tète efficacement (c'est-à-dire par suctions profondes et lentes entrecoupées de pauses)? <i>Pas de succion du tout - Succion non efficace - Succion efficace</i> Désobstruer le nez du nourrisson s'il est bouché et gêne l'allaitement. - Regarder la bouche pour détecter des ulcérations ou plaques blanches (muguet)			Pas de poids faible pour l'âge et aucun autre signe d'alimentation inadéquate.	PAS DE PROBLÈME D'ALIMENTATION	➢ Apprendre à soigner le nourrisson à domicile. ➢ Féliciter la mère pour la bonne alimentation du nourrisson

ENSUITE, VERIFIER L'ETAT VACCINAL DU NOURRISSON

CALENDRIER DE VACCINATION :	AGE	VACCINS
	Naissance 6 Semaines	BCG + Polio-0 ((DTC-HepB-Hib – Rota-PCV13) 1+ Polio 1+ HB DN

EVALUER LES AUTRES PROBLEMES :

VERIFIER L'ETAT DE SANTE DE LA MERE :

TRAITER LE NOURRISSON ET CONSEILLER LA MERE

➤ **Donner un antibiotique approprié par voie orale**

Pour traiter l'infection bactérienne locale :

ANTIBIOTIQUE : AMOXICILLINE

	AMOXICILLINE ➤ Donner 3 fois par jour pendant 5 jours		Amoxicilline injectable : 100 mg/ kg/j à répartir en 3 doses
ÂGE ou POIDS	SIROP 1cuillère-mesure de 5 ml = 250 mg	SIROP 1 cuillère-mesure de 5 ml = 125 mg	
Naissance à 1 mois (< 3 kg)		1/2	
de 1 mois à 2 mois (3-4 kg)	1/2	1	

➤ **Donner de la vitamine K1 en IM : 5 à 10 mg**

➤ **Donner la première dose d'antibiotique en intramusculaire**

➤ Donner la première dose d'Amoxicilline et de gentamicine en intramusculaire.

POIDS	GENTAMICINE Dose: 2.5 mg par kg	
	Flacon non dilué, de 2 ml contenant 10 mg = 2 ml à 5 mg/ml	Ajouter 6 ml d'eau stérilisée à un flacon de 2 ml contenant 40 mg* = 8 ml à 5 mg/ml
1 kg	0,5 ml	
2 kg	1 ml	
3 kg	1,5 ml	
4 kg	2 ml	
5 kg	2,5 ml	

* Ne pas utiliser de gentamicine 40 mg/ml non diluée. La dose est 1/4 de celle mentionnée ci-dessus.

➤ Il est préférable de transférer le nourrisson classé POSSIBILITÉ D'INFECTION BACTÉRIENNE GRAVE, mais si le transfert n'est pas possible, donner de l'Amoxicilline et de la gentamicine pendant 5 jours au moins. Donner l'Amoxicilline toutes les 6 heures plus de la gentamicine toutes les 8 heures. Pour le nourrisson d'une semaine, donner de la gentamicine toutes les 12 heures.

TRAITER LE NOURRISSON ET CONSEILLER LA MÈRE

➤ ***Pour traiter la diarrhée, voir tableau TRAITER L'ENFANT***

➤ ***Vacciner tout nourrisson malade, si nécessaire***

➤ ***Apprendre à la mère à traiter les infections locales à domicile***

- Expliquer comment et pourquoi le traitement est administré.
- Observer la mère pendant qu'elle donne le premier traitement au centre de santé.
- Explique la fréquence d'administration journalière du traitement à la mère.
- Demander à la mère de revenir au centre si l'infection s'aggrave.

Pour traiter les pustules cutanées ou l'infection ombilicale

La mère doit:

- Se laver les mains
- Nettoyer doucement le pus et les croûtes avec de l'eau et du savon
- Sécher la zone avec un linge propre
- Appliquer l'Eosine aqueuse 2% ou la Bétadine jaune dermique
- Se laver les mains à nouveau

Pour traiter le muguet (ulcérations ou plaques blanches dans la bouche)

La mère doit:

- Se laver les mains
- Nettoyer la bouche avec un tissu propre et doux enroulé autour du doigt et mouillé avec de l'eau salée
- Badigeonner la bouche et la langue avec la nystatine suspension (100 000 unités/ml) : **1 à 2 ml x 4 /jour pendant 7 jours**
- Se laver les mains à nouveau

TRAITER LE NOURRISSON ET CONSEILLER LA MÈRE

➤ **Apprendre à la mère comment bien positionner le nourrisson et assurer une bonne prise du sein**

- La tête et le corps du nourrisson sont dans le même axe
 - Le nourrisson doit faire face au sein, et son nez en face du mamelon
 - Le corps du nourrisson doit être proche du corps de la mère
 - La mère doit soutenir tout le corps du nourrisson, pas seulement la nuque et les épaules.
- Montrer à la mère comment aider le nourrisson à prendre le sein. Elle doit:
- toucher les lèvres du nourrisson avec son mamelon
 - attendre que la bouche du nourrisson soit grande ouverte
 - approcher rapidement le nourrisson du sein en veillant que la lèvre inférieure du nourrisson soit bien en-dessous du mamelon.
- Vérifier la bonne prise du sein et l'efficacité de la succion. Si la prise du sein ou la succion n'est pas correcte, recommencer.
- Les 4 Signes de la bonne prise du sein sont :
- Le menton touche le sein
 - La bouche est grande ouverte
 - La lèvre inférieure est éversée vers l'extérieur
 - L'aréole est plus visible au-dessus qu'au-dessous de la bouche
- (Tous ces signes doivent être présents pour que la prise du sein soit bonne)

➤ **Conseiller la mère sur les soins du nourrisson à domicile**

- ALIMENTS LIQUIDES } Allaiter fréquemment, aussi souvent et aussi longtemps que le nourrisson le réclame, jour et nuit, que le nourrisson soit malade ou en bonne santé.

- QUAND REVENIR

Visite de suivi :

Si le nourrisson a:	Revenir pour visite de suivi après:
INFECTION BACTÉRIENNE LOCALE PROBLÈME QUELCONQUE D'ALIMENTATION	2 jours
MUGUET	5 jours
POIDS FAIBLE POUR L'ÂGE	14 jours

Conseiller à la mère de revenir immédiatement si le nourrisson présente l'un des signes suivants :

Difficulté à téter ou à boire
Présence de fièvre
Respiration rapide
Respiration difficile
Présence de sang dans les selles
Aggravation de l'état de santé

- S'ASSURER QUE LE NOURRISSON EST TOUJOURS MAINTENU AU CHAUD.
- Quand il fait froid couvrir la tête et les pieds du nourrisson et l'habiller chaudement.

SUIVI DES SOINS DU NOURRISSON MALADE

➤ **INFECTION BACTÉRIENNE LOCALE**

Après 2 jours:

Regarder l'ombilic. Est-il rouge ou suppure-t-il? La rougeur s'étend-elle à la peau?
Regarder les pustules cutanées. Sont-elles nombreuses ou sévères?

Traitement:

- Si **le pus ou la rougeur persistent ou s'aggravent**, transférer le nourrisson à l'hôpital.
- Si **le pus et la rougeur ont diminué**, féliciter la mère et lui demander de poursuivre le traitement antibiotique pendant encore 5 jours et de continuer de traiter l'infection locale à domicile.

INFECTION LOCALE

SUIVI DES SOINS

SUIVI DES SOINS DU NOURRISSON MALADE

➤ **PROBLÈME D'ALIMENTATION**

Après 2 jours:

Réévaluer l'alimentation. > Voir *Evaluer les problèmes d'alimentation ou d'insuffisance pondérale* ci-dessus.

Poser des questions sur les problèmes d'alimentation notés lors de la première visite.

- Conseiller la mère sur tout problème d'alimentation nouveau ou persistant. Si vous conseillez à la mère d'apporter des changements sensibles à l'alimentation, lui conseiller de revenir pour une nouvelle visite de suivi.
- Si le poids du nourrisson est faible pour son âge et/ou pour sa taille, conseiller à la mère de revenir 14 jours après la première visite pour une nouvelle pesée.

Exception:

Si aucune amélioration ne semble prévisible; ou si le nourrisson a **perdu du poids**, le référer.

➤ **POIDS FAIBLE POUR L'ÂGE**

Après 14 jours:

Peser le nourrisson et déterminer si son poids est toujours faible pour son âge et/ou pour sa taille.

Réévaluer l'alimentation. > Voir *Evaluer les problèmes d'alimentation ou d'insuffisance pondérale* ci-dessus.

- Si le poids du nourrisson **n'est plus faible pour son âge et/ou pour sa taille**, féliciter la mère et l'encourager à continuer.
- Si le poids du nourrisson est **encore faible pour son âge et/ou pour sa taille, mais si le nourrisson se nourrit bien**, féliciter la mère. Lui demander de revenir peser son enfant dans un mois ou lorsqu'elle reviendra pour la vaccination.
- Si le poids du nourrisson est **encore faible pour son âge et/ou pour sa taille, et qu'il a toujours un problème d'alimentation**, conseiller la mère sur le problème d'alimentation. Lui demander de revenir dans 14 jours (ou lorsqu'elle reviendra pour la vaccination, si celle-ci se fera dans les 2 semaines). Continuer le suivi du nourrisson toutes les 2 semaines jusqu'à ce qu'il se nourrisse bien et gagne du poids régulièrement, ou que son poids ne soit plus faible pour son âge et/ou pour sa taille.

Exception:

Si aucune amélioration ne semble prévisible; ou si le nourrisson a **perdu du poids**, le référer.

➤ **MUGUET**

Après 5 jours:

Rechercher les ulcérations ou plaques blanches dans la bouche (muguet).

Réévaluer l'alimentation. > Voir *Evaluer les problèmes d'alimentation ou d'insuffisance pondérale* ci-dessus.

- Si **le muguet s'est aggravé**, ou si le nourrisson a des problèmes de succion et de prise de sein, le référer à l'hôpital.
- Si **le muguet est le même ou a diminué**, et si le nourrisson se **nourrit bien**, continuer le traitement à la Nystatine pendant 5 jours.



EVALUER CLASSER ET TRAITER LE NOUVEAU-NE MALADE DE 0 A 1 SEMAINE

LA REANIMATION NEONATALE



Préalables : - Etre prêt pour une réanimation néonatale à chaque accouchement (apprêter le matériel de réanimation)

- Suivre correctement toutes les étapes sans perdre de temps

- Avoir une bonne collaboration entre tous les membres de l'équipe

Dès la naissance

Dans les 30 premières secondes

Sécher l'enfant avec un linge propre et le mettre dans un endroit où il sera au chaud

Observer s'il :

- respire ou pleure
- a un bon tonus musculaire
- a une coloration rosée

Si oui,

Appliquer les soins courants

Si non :

- Mettre la tête de l'enfant en extension de sorte à dégager les voies aériennes
- Aspirer les voies aériennes
- Administrer de l'oxygène le cas échéant
- Puis regarder la respiration et la coloration :

Si le nouveau-né respire et est rose appliquer les soins courants et surveiller étroitement

Si pas de respiration et nouveau-né cyanosé, passer à l'étape suivante

Dans les 30 secondes suivantes

A l'aide d'un masque correctement ajusté, administrer à l'enfant, 5 insufflations lentes au ballon.

Si respiration,

- appliquer les soins courants
- puis surveiller étroitement

Si pas de respiration,

- vérifier si la position du nouveau-né est bonne et si le masque est bien ajusté ;
- ajuster la position le cas échéant puis ventiler au masque et au ballon.
- Si la poitrine ne se soulève pas bien, procéder à une aspiration des voies aériennes
- Vérifier la fréquence cardiaque (battement du cordon ombilical)

Si < 60/min, pratiquer un massage cardiaque combiné à la ventilation au masque.

Si > 60/min, continuer à ventiler au masque à raison d'environ 40 insufflations par minute en s'assurant que la cage thoracique se soulève normalement (utiliser de l'oxygène s'il y en a)

Si pas d'amélioration au bout de 15 minutes, passer 5ml/kg de G10 par le cordon et référer le nouveau-né

- Toutes les 1 à 2 minutes, arrêter la ventilation et regarder si le pouls ou la respiration se sont améliorés
- Arrêter le massage une fois que la fréquence cardiaque dépasse les 100/min
- Arrêter la ventilation au masque lorsque la fréquence respiratoire est supérieure à 30/min
- Continuer l'oxygénation jusqu'à ce que le nouveau-né devienne rose ou commence à bouger.



EVALUER, CLASSER ET TRAITER LE NOUVEAU-NE MALADE AGE DE 0 A 1 SEMAINE



EVALUER

DEMANDER A LA MERE QUELS SONT LES PROBLEMES DE SANTE DU NOUVEAU-NE

- Déterminer s'il s'agit d'une première visite ou d'une visite de suivi pour ce problème.
- S'il s'agit d'une visite de suivi, se référer aux instructions dans le tableau de suivi.
- S'il s'agit d'une première visite, évaluer le nouveau-né comme suit :

CLASSER

POUR CLASSER LA MALADIE, UTILISER TOUS LES CADRES QUI CORRESPONDENT AUX SYMPTOMES ET PROBLEMES DU NOUVEAU-NE

IDENTIFIER LE TRAITEMENT

CHEZ TOUT NOUVEAU-NE RECHERCHER UNE MALADIE GRAVE OU INFECTION BACTERIENNE GRAVE, UNE INFECTION BACTERIENNE LOCALE ET UNE HYPOTHERMIE

DEMANDER:

- Le nouveau-né a-t-il eu des convulsions ?
- Le nouveau-né est-il incapable de s'alimenter ?

REGARDER, RECHERCHER:

- Le nouveau-né est-il léthargique?
- Le nouveau-né a-t-il des convulsions?
- Compter la respiration pendant 1 minute Répéter si élevée ($\geq 60/\text{mn}$)
- Rechercher un tirage sous-costal marqué
- Rechercher un geignement expiratoire
- Regarder les mouvements du nouveau-né:
 - Le nouveau-né ne bouge que si on le stimule?
 - Le nouveau-né ne fait pas de mouvements même si on le stimule?
- Mesurer la température axillaire.
 - est-elle $> 37^{\circ}\text{C}$?
 - est-elle $\leq 35^{\circ}\text{C}$?
 - est-elle comprise entre $35^{\circ}\text{C} < T^{\circ} < 36^{\circ}\text{C}$?
- Rechercher un ictère précoce
- Rechercher une pâleur sévère
- Rechercher une cyanose généralisée
- Regarder l'ombilic. Est-il rouge ou purulent?
- Rechercher des pustules sur la peau.

CLASSER

LE NOUVEAU-NE DOIT ETRE CALME

SIGNES

CLASSER

(le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)

Présence d'un des signes suivants : • Léthargie • Convulsions ou • Incapable de s'alimenter ou • Respiration rapide (≥ 60 cycles/minute) ou • Respiration lente (< 30 cycles/minute ou pause > 30 secondes) • Tirage sous costal marqué ou • Geignement ou • Pas de mouvements même si stimulation ou • Ne bouge que si stimulation ou • Fièvre ($T^{\circ} > 37,5^{\circ}\text{C}$) ou • Hypothermie sévère ($T^{\circ} \leq 35,5^{\circ}\text{C}$) ou • Pustules nombreuses et/ou sévères ou • Ictère précoce ou • Pâleur sévère ou • Cyanose généralisée ou • Rougeur ombilicale diffuse (s'étendant à la zone périombilicale)	MALADIE GRAVE OU INFECTION BACTERIENNE GRAVE	➤ Réchauffer le nouveau-né si hypothermie ➤ Administer la première dose de paracétamol en cas d'hyperthermie ➤ Administer la première dose d'antibiotiques pré-transfert en IM ➤ Administer du diazépam en intra rectal en cas de convulsions en cours ➤ Prévenir l'hypoglycémie ➤ Expliquer à la mère comment tenir le nouveau-né au chaud pendant la référence ➤ Référer d'URGENCE le nouveau-né à l'hôpital
• Ombilic rouge ou ombilic purulent ou • Pustules cutanées	INFECTION BACTERIENNE LOCALE	➤ Donner un antibiotique approprié par voie orale ➤ Apprendre à la mère comment soigner les infections locales à domicile ➤ Conseiller la mère sur les soins du nouveau-né à domicile ➤ Expliquer quand revenir immédiatement ➤ Revoir le nouveau-né dans 2 jours
• Hypothermie modérée (Température entre $35,5^{\circ}\text{C}$ et $36,5^{\circ}\text{C}$)	HYPOTHERMIE MODEREE	➤ Réchauffer le nouveau-né par un contact peau contre peau (voir tableau réchauffer le bébé et le garder au chaud) ➤ Réévaluer l'hypothermie après 1 heure et décider en suivant les instructions du tableau. ➤ Expliquer quand revenir immédiatement ➤ Revoir le nouveau-né dans 2 jours
Pas de signe d'infection bactérienne grave ou locale et Pas d'hypothermie	PAS D'INFECTION BACTERIENNE ET PAS D'HYPOTHERMIE	➤ Traiter le nouveau-né pour tout autre problème ➤ Conseiller la mère sur les soins du nouveau-né à domicile ➤ Expliquer quand revenir immédiatement

*Ces seuils sont basés sur la température axillaire.
Les seuils pour la température rectale sont approximativement de $0,5^{\circ}\text{C}$ plus haut

RECHERCHER UN POIDS FAIBLE

DEMANDER

• Quel est le poids du nouveau-né à la naissance?

OBSERVER:

• Regarder le poids actuel du nouveau-né;
- est-il < 1500 grammes?
- est-il compris entre 1500g et 2500g?

Classer

SIGNES

CLASSER

TRAITEMENT

(le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)

• Poids < 1500 g	POIDS TRES FAIBLE	➤ Maintenir le nouveau-né au chaud avant et pendant l'évacuation ➤ Prévenir l'hypoglycémie ➤ Référer d'URGENCE le nouveau-né à l'hôpital
Poids compris entre 1500g et 2000		Soins Mère Kangourou si possible ou référer
• Poids compris entre 2000g et 2500g	POIDS FAIBLE POIDS FAIBLE	➤ Maintenir le nouveau-né au chaud ➤ Apprendre à la mère à tenir le nouveau-né au chaud à domicile ➤ Encourager la mère à allaiter toutes les 2 ou 3 heures ➤ Revoir le nouveau-né tous les jours jusqu'à ce qu'il s'alimente correctement, qu'il prenne du poids et que la température corporelle reste stable ➤ Ensuite revoir le nouveau-né toutes les semaines après la dernière visite ➤ Expliquer quand revenir immédiatement
• Poids ≥ 2500 g	PAS DE POIDS FAIBLE	➤ Traiter le nouveau-né pour tout autre problème ➤ Conseiller la mère sur les soins du nouveau-né à domicile ➤ Suivre la croissance du nouveau-né toutes les semaines ➤ Expliquer quand revenir immédiatement

RECHERCHER UNE INFECTION OCULAIRE

DEMANDER

• Le nouveau-né a-t-il du pus dans les yeux?

REGARDER :

• Inspecter les yeux du nouveau-né :
- Sont-ils purulents?
- Sont-ils enflés?

Classer

• Yeux enflés et purulents	INFECTION OCULAIRE PROBABLE A CHLAMYDIAE OU A GONOCOQUE	➤ Nettoyer les yeux avec du sérum physiologique pour éliminer autant de pus que possible ➤ Administrer de la Ceftriaxone 50 mg/kg jusqu'à un total de 150 mg en IM en une fois ➤ Appliquer la première dose de pommade ophtalmique à la tétracycline dans les yeux ➤ Référer dans un centre spécialisé
• Yeux purulents	CONJONCTIVITE PURULENTE DU NOUVEAU-NE	➤ Apprendre à la mère comment nettoyer les yeux à l'eau ou au lait maternel et comment appliquer de la pommade ophtalmique à la tétracycline dans les yeux ➤ La mère doit se laver les mains avant et après ➤ Appliquer la première dose de pommade ophtalmique à la tétracycline dans les yeux ➤ Dire à la mère de nettoyer les yeux et de mettre la pommade ophtalmique à la tétracycline quatre fois par jour pendant 5 jours ➤ Donner à la mère un tube de pommade ophtalmique à la tétracycline ➤ Expliquer quand revenir immédiatement ➤ Revoir le nouveau-né 5 jours plus tard
• Pas d'yeux enflés ni purulents	PAS D'INFECTION OCULAIRE	➤ Traiter le nouveau-né pour tout autre problème ➤ Conseiller la mère sur les soins du nouveau-né à domicile ➤ Expliquer quand revenir immédiatement

PUIS RECHERCHER UN ICTERE

Classer l'ictère	
SI OUI, DEMANDER : DEPUIS QUAND	OBSERVER ET RECHERCHER: coloration jaunâtre de la paume des mains et des plantes des pieds, des <u>muqueuses</u> , et des conjonctives des yeux ?

SIGNES	CLASSER	TRAITEMENT (le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)
• Nouveau-né âgé de moins de 24 h : Coloration jaune de la peau et des muqueuses OU • Nouveau-né de plus de 24 h : Coloration jaune de la peau et des muqueuses + l'un des signes suivants : fièvre, hypothermie, manifestations infectieuses	ICTERE PATHOLOGIQUE	➤ Traiter pour prévenir l'hypoglycémie : encourager l'allaitement, en cas de difficulté, exprimer le lait et le donner à la cuillère. ➤ Conseiller à la mère comment garder le nouveau-né au chaud pendant la référence ➤ Référer d'urgence le nouveau-né à l'hôpital.
• Nouveau-né âgé de plus de 48h : Coloration jaune de la peau et des muqueuses	ICTERE PHYSIOLOGIQUE	➤ Rassurer la mère ➤ Conseiller sur l'alimentation ➤ Conseiller sur le suivi de la croissance
• Coloration normale de la peau et des muqueuses	PAS D'ICTERE	➤ Conseiller sur l'alimentation ➤ Conseiller sur le suivi de la croissance

RECHERCHER UN RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH

DEMANDER OU RECHERCHER LA SEROLOGIE VIH DE LA MERE:

- La mère est-elle séropositive connue au VIH ?
- La sérologie VIH de la mère était-elle négative pendant la grossesse ?

Classer

SIGNES

CLASSER

TRAITEMENT

(le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)

• Séropositivité VIH de la mère connue	INFECTION VIH POSSIBLE/ EXPOSE AU VIH	➤ Débuter le traitement pour les autres classifications ➤ Administrer le traitement ARV au nouveau-né ➤ Donner des conseils appropriés pour l'alimentation ➤ Conseiller la mère pour les soins à domicile ➤ Faire la PCR à 6 semaines ➤ Revoir le nouveau-né dans 7 jours ➤ Conseiller à la mère de faire dépister toute la famille ➤ Donner des conseils à la mère sur les soins du nouveau-né à domicile ➤ Expliquer à la mère quand revenir immédiatement
• Sérologie VIH de la mère inconnue	NOUVEAU-NE A RISQUE D'INFECTION VIH	➤ Conseiller sur les bénéfices d'un test de dépistage du VIH de la mère et du nouveau-né et faire le test si possible. ➤ Conseiller de revenir immédiatement dès l'apparition de tout nouveau problème ➤ Donner des conseils pour l'allaitement exclusif ➤ Donner des conseils à la mère sur les soins du nouveau-né à domicile
• Sérologie VIH de la mère négative	PAS DE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH	➤ Donner des conseils à la mère sur les soins du nouveau-né à domicile ➤ Donner des conseils pour l'allaitement exclusif ➤ Expliquer quand revenir immédiatement

RECHERCHER LES DIFFICULTES D'ALIMENTATION

DEMANDER:	OBSERVER:	Classer L'ALIMENTATION
- Le nouveau-né a-t-il des difficultés à se nourrir? - Le nouveau-né est-il nourri au sein? Oui ____ Non ____ Si non, évaluer l'alimentation de remplacement Si oui, combien de fois en 24 heures? _____ - Le nouveau-né reçoit-il d'autres aliments ou liquides en plus du lait maternel? Si oui lesquels?	- Regarder la bouche du nouveau-né pour détecter : - un muguet, - une malformation au niveau de la bouche (un bec de lièvre, une fente palatine)	

Si le nouveau-né :

- a des difficultés à se nourrir,
 - est allaité moins de 8 fois en 24 h,
 - consomme d'autres aliments ou d'autres liquides,
- ET
- ne présente aucun signe justifiant le transfert d'urgence à l'hôpital,

Alors évaluer l'allaitement :

- Le nouveau-né a-t-il été nourri au sein durant l'heure précédente?
Si le nouveau-né a été allaité durant l'heure précédente, demander à la mère si elle peut attendre et vous dire quand le nouveau-né réclamera le sein de nouveau.
Si le nouveau-né n'a pas été allaité durant l'heure précédente, demander à la mère de le mettre au sein.
Observer l'allaitement pendant 4 minutes :
• Le nouveau-né peut-il bien prendre le sein?

Pas de prise de sein - Mauvaise prise de sein - Bonne prise de sein

POUR VÉRIFIER LA PRISE DU SEIN, REGARDER SI:

- Le menton touche le sein
 - La bouche est grande ouverte
 - La lèvre inférieure est éversée vers l'extérieur
 - L'aréole est plus visible au-dessus qu'en-dessous de la bouche
- (Tous ces signes doivent être présents pour que la prise du sein soit bonne)

- Est-ce que le nouveau-né tète efficacement (c'est-à-dire par suctions profondes et lentes entrecoupées de pauses)?

Pas de succion du tout - Succion non efficace - Succion efficace

- Si Mauvaise prise du sein ou succion non efficace,
 - examiner les mamelons de la mère pour rechercher des anomalies (mamelons courts, plats, ombiliqués, gerçures, crevasses)
 - voir si le nez du nouveau-né est obstrué

SIGNES	CLASSER	TRAITEMENT (le traitement urgent avant évacuation est en caractère gras)
- Incapable de se nourrir - Pas de prise du sein - Pas de succion du tout	POSSIBILITE DE MALADIE GRAVE OU INFECTION BACTERIENNE GRAVE	Administer la première dose d'antibiotiques pré-transfert en IM Commencer à réchauffer le nouveau-né si hypothermie Prévenir l'hypoglycémie Expliquer à la mère comment le garder au chaud pendant l'évacuation Référer le nouveau-né à l'hôpital +++
- Mauvaise prise du sein, - ou - Succion non efficace, - ou - Moins de 8 tétées en 24 heures, - ou - Reçoit d'autres aliments ou liquides en plus du lait maternel, - ou - Muguet (ulcérations ou plaques blanches dans la bouche) - ou - Malformation au niveau de la bouche	PROBLÈME D'ALIMENTATION	- Si la prise du sein est mauvaise ou si la succion n'est pas efficace : - expliquer la bonne position et la bonne prise du sein. - aider la mère à traiter les anomalies du mamelon si elles existent - désobstruer le nez du nouveau-né s'il est bouché - Si la mère allaite moins de 8 fois en 24 heures, lui conseiller d'allaiter plus souvent. - Si pas d'allaitement : - Référer pour conseils sur l'allaitement et éventuellement la relactation si mère séronégative au VIH. - Si alimentation de remplacement app - Apprendre à la mère à préparer correctement un substitut au lait maternel et à utiliser une tasse surtout si la mère est séropositive au VIH. - Vérifier les conditions AFADS - En cas de muguet, apprendre à la mère à le traiter à domicile. - En cas de malformation à la bouche, référer pour prise en charge - Apprendre à la mère à soigner le nouveau-né à domicile. - Expliquer quand revenir immédiatement - Revoir dans 2 jours.
Aucun signe d'alimentation inadéquate	PAS DE PROBLÈME D'ALIMENTATION	- Apprendre à la mère à soigner le nouveau-né à domicile. - Féliciter la mère pour la bonne alimentation du nouveau-né - Expliquer quand revenir immédiatement

VERIFIER LE STATUT VACCINAL DU NOUVEAU-NE :

CALENDRIER DE VACCINATION :	<u>AGE</u>	<u>VACCIN</u>
	Naissance	BCG Polio 0

Donner rendez-vous à **6 semaines** pour le (DTC-HépB-Hib-Rota-PCV13) **1 + Polio1**

EVALUER LES AUTRES PROBLEMES

En cas de malformations congénitales :

Référer les cas urgents : bec de lièvre associé à la fente palatine, occlusion intestinale, myéloméningocèle, omphalocèle, luxation congénitale de la hanche prononcée

TRAITER LE NOUVEAU-NE ET CONSEILLER LA MERE

➤ **Donner la dose d'antibiotiques pré-transferts**

➤ Donner la première dose d'Amoxicilline et de Gentamicine en intramusculaire.

POIDS	GENTAMICINE Dose : 2,5 mg par kg		AMOXICILLINE Dose : 100 mg par Kg
	Flacon non dilué, de 2 ml contenant 20 mg (soit 10 mg/ml)	* Flacon non dilué, de 2 ml contenant 80 mg (soit 40 mg/ml) : Ajouter 6 ml d'eau stérilisée à un flacon de 2 ml pour obtenir 8 ml (soit 10 mg/ml)	Ajouter 2 ml d'eau stérile à 1 flacon de 500 mg pour obtenir 250 mg/ml (soit 25 mg/0,1 ml)
1 kg		0,25 ml	0,4ml
2 kg		0,50 ml	0,8 ml
3 kg		0,75 ml	1,2 ml
4 kg		1,00 ml	1,6 ml
5 kg		1,25 ml	2 ml

** Ne pas utiliser de gentamicine 40 mg/ml non diluée.*

➤ Il faut référer le nouveau-né classé **POSSIBILITE de MALADIE GRAVE** ou **INFECTION BACTERIENNE GRAVE**.

Mais si la référence n'est pas possible, donner de l'Amoxicilline et de la Gentamicine pendant 5 jours au moins :

Donner l'Amoxicilline toutes les 6 heures, **plus** de la gentamicine toutes les 12 heures.

➤ **Donner un antibiotique approprié par voie orale**

Pour traiter l'infection bactérienne locale :

ANTIBIOTIQUE DE PREMIÈRE INTENTION : **AMOXICILLINE**

	AMOXICILLINE Sirop 125 mg / 5 ml
Posologie selon le poids	50-100 mg/kg/jour
Posologie selon l'âge (de la naissance à 7jours)	5 ml (1cm) Donner 2 fois par jour pendant 5 jours

TRAITER LE NOUVEAU-NE ET CONSEILLER LA MERE

➤ ***Apprendre à la mère à traiter les infections locales à domicile***

- Expliquer comment et pourquoi le traitement est administré.
- Observer la mère pendant qu'elle donne le premier traitement au centre de santé.
- Expliquer à la mère la fréquence d'administration des médicaments (Dire à la mère de donner le traitement 2 fois par jour).
- Dire à la mère qu'elle doit revenir au centre de santé si l'infection s'aggrave.

Pour traiter les pustules cutanées ou l'infection ombilicale

La mère doit :

- Se laver les mains à l'eau propre et au savon
- Nettoyer doucement le pus et la croûte avec de l'eau et du savon
- Sécher la zone avec un linge propre
- Appliquer du violet de gentiane
- Se laver les mains à nouveau

Pour traiter le muguet (ulcérations ou plaques blanches dans la bouche)

La mère doit :

- Se laver les mains à l'eau propre et au savon
- Nettoyer la bouche avec du tissu propre et doux enroulé autour du doigt et mouillé avec de l'eau salée
- Badigeonner la bouche et la langue avec la nystatine suspension
- Se laver les mains à nouveau

➤ ***Traiter l'infection oculaire et apprendre à la mère comment le faire à domicile***

- Nettoyer les yeux 4 fois par jour.
 - Se laver les mains à l'eau propre et au savon.
 - Mouiller du linge propre et nettoyer le pus des yeux.
- Ensuite, appliquer la pommade ophtalmique à la tétracycline dans les yeux 4 fois par jour.
 - Ouvrir les yeux du nouveau-né.
 - Appliquer la pommade ophtalmique à la tétracycline sur la face interne de la paupière inférieure.
 - Se laver les mains.
- Remettre la pommade ophtalmique à la tétracycline à la mère pour les soins à domicile.
- Le traitement doit être poursuivi jusqu'à ce que la rougeur des yeux disparaisse, sans dépasser 15 jours.
- Ne pas appliquer d'autres pommades ou collyres ou autre chose dans les yeux

TRAITER LE NOUVEAU-NE ET CONSEILLER LA MERE

➤ **RECHAUFFER LE NOUVEAU-NE ET LE GARDER AU CHAUD**

► **Réchauffer le nouveau-né par le contact peau à peau**

- Retirer au nouveau-né ses vêtements froids
- Le munir d'une couche, d'un bonnet et de chaussettes, puis le mettre sur la poitrine de sa mère
- Couvrir le nouveau-né sur la poitrine de sa mère avec les vêtements de celle-ci, ainsi qu'une couverture préchauffée
- Vérifier la température toutes les heures jusqu'à ce qu'elle soit normale
- Garder le nouveau-né avec sa mère
- Demander à la mère d'allaiter le nouveau-né fréquemment

► **Si le contact peau à peau n'est pas possible**

- Si un appareil de chauffage radiant est disponible, l'utiliser pour réchauffer le nouveau-né, ou
- Réchauffer la salle avec du matériel de chauffage et habiller le nouveau-né avec des vêtements chauds et le couvrir avec une couverture chaude

► **Réévaluer après une heure**

- Rechercher les signes de « maladie grave »
- Mesurer la température axillaire

- S'il existe un signe quelconque de « maladie grave » ou si la température reste en dessous de 36,5°C, **évacuer rapidement à l'hôpital après avoir fait le traitement pré-transfert** pour « maladie grave ».

- S'il n'existe aucun signe de « maladie grave » et la température est supérieure ou égale à 36,5 °C,
 - Conseiller la mère sur comment garder le nouveau-né au chaud à la maison
 - Conseiller la mère sur les soins à domicile
 - Conseiller la mère sur quand revenir immédiatement
 - Revoir le nouveau-né dans 2 jours

TRAITER LE NOUVEAU-NE ET CONSEILLER LA MERE

➤ *RECHAUFFER LE NOUVEAU-NE PAR LE CONTACT PEAU A PEAU ET LE GARDER AU CHAUD*



TRAITER LE NOUVEAU-NE ET CONSEILLER LA MERE

➤ ***Apprendre à la mère comment garder le nouveau-né au chaud pendant le transfert à l'hôpital***

➤ **Réchauffer le nouveau-né par le contact peau à peau**

- Contact peau à peau
- Garder le nouveau-né habillé avec chemise, bonnet, gants, chaussettes et l'envelopper dans une couverture sèche et douce

➤ ***Apprendre à la mère comment garder le nouveau-né au chaud à la maison***

➤ **Réchauffer le nouveau-né par le contact peau à peau**

- Contact peau à peau aussi souvent que possible, jour et nuit
- Quand le nouveau-né n'est pas en contact peau à peau, le garder habillé ou couvert aussi souvent que possible à tout moment.
Habiller le nouveau-né avec chemise, bonnet, gants et chaussettes et le couvrir
- Le garder dans le même lit que sa mère
- Changer les habits dès qu'ils sont mouillés
- Garder la chambre chaude
- Eviter de laver le nouveau-né jusqu'aux prochaines 24 heures

TRAITER LE NOUVEAU-NE ET CONSEILLER LA MERE

- *Si la mère est séropositive connue au VIH et
Si ni la mère, ni le nouveau-né n'a suivi correctement le protocole PTME et
Si le nouveau-né est âgé de moins de 72h,*
 - *Donner des conseils sur l'allaitement,*
 - *Administer la première dose d'ARV,*
 - *Conseiller à la mère de faire dépister toute la famille,*
 - *Revoir le nouveau-né dans 7 jours.*

TRAITER LE NOUVEAU-NE ET CONSEILLER LA MERE

➤ **Traiter le nouveau-né qui convulse avec du diazépam**

Traiter les convulsions avec du diazépam

Administer le diazépam par voie rectale :

- Aspirer la quantité de diazépam nécessaire dans une seringue
- Rajouter 1 à 2 ml d'eau distillée
- **Retirer l'aiguille de la seringue**
- Insérer la seringue (**sans aiguille**) à 1 ou 2 cm dans le rectum et injecter la solution de diazépam
- Tenir les fesses serrées pendant quelques minutes

POIDS	DIAZEPAM A ADMINISTRER PAR VOIE RECTALE Solution de 10 mg/2ml Dose: 0,5 mg/kg
< 3 kg	0,25 ml
3 à < 5kg	0,5ml

Dégager les voies respiratoires :

- Placer le nouveau-né sur le côté,
- Ne rien mettre dans sa bouche.
- Si les lèvres et la langue sont bleuâtres, ouvrir la bouche pour s'assurer que les voies respiratoires sont libres. Si besoin, aspirer les sécrétions de la gorge avec une sonde introduite par la narine (à défaut utiliser une poire)

➤ **Vacciner le nouveau-né malade avec le BCG et Polio 0, si pas de contre-indication**

➤ **Traiter le nouveau-né pour éviter l'hypoglycémie**

Traiter le nouveau-né pour éviter l'hypoglycémie

➤ **Si le nouveau-né est capable de téter :**

- Demander à la mère de l'allaiter

➤ **Si le nouveau-né est incapable de téter mais est capable d'avaler :**

- Donner du lait exprimé ou un substitut de lait maternel.
Si ni l'un ni l'autre n'est disponible, donner de l'eau sucrée.
- Donner 30 à 50 ml de lait ou d'eau sucrée avant le départ. Pour faire de l'eau sucrée, dissoudre 4 carreaux de sucre (20 grammes) dans une tasse de 200 ml d'eau propre.

➤ **Si le nouveau-né est incapable d'avaler :**

Donner 50 ml de lait ou d'eau sucrée par sonde nasogastrique.

TRAITER LE NOUVEAU-NE ET CONSEILLER LA MERE

➤ **Apprendre à la mère comment bien positionner le nouveau-né et assurer une bonne prise du sein**

➤ **Montrer à la mère comment tenir le nouveau-né**

- la tête du nouveau-né dans le pli du coude
- les fesses dans la paume de la mère
- la tête et le corps du nouveau-né doivent être dans le même axe

SUIVI DES SOINS DU NOUVEAU-NE MALADE

➤ **RECHERCHER TOUT SIGNE DE "POSSIBILITE DE MALADIE GRAVE OU INFECTION BACTERIENNE GRAVE" PENDANT LA VISITE DE SUIVI CHEZ TOUT NOUVEAU-NE**

➤ **CONSEILLER LA MERE SUR L'ESPACEMENT DES NAISSANCES**

➤ **INFECTION BACTERIENNE LOCALE**

Après 2 jours :

- Regarder l'ombilic, est-il rouge ou purulent?
- Rechercher des pustules cutanées

➤ **Si le pus ou la rougeur de l'ombilic persistent ou s'aggravent**, transférer le nouveau-né à l'hôpital

➤ **Si la situation s'est améliorée (diminution du pus et de la rougeur)**, dire à la mère de continuer l'amoxicilline pendant encore 3 jours et de continuer de traiter l'infection locale à domicile

➤ **INFECTION OCULAIRE**

Après 5 jours :

- Regarder les yeux du nouveau-né: sont-ils enflés et/ou purulents?

➤ Si les yeux sont enflés et purulents, demander à la mère de continuer d'appliquer la pommade ophtalmique à la tétracycline pendant encore 3 jours

➤ **HYPOTHERMIE MODEREE**

Après 2 jours :

- Evaluer la température du nouveau-né:

➤ Si elle est **< 36,5°C** ou **> 37,5°C**, **référer le nouveau-né à l'hôpital**

➤ Si elle est comprise entre **36,5°C** et **37,5°C**, **conseiller la mère sur comment continuer à tenir le nouveau-né au chaud à domicile**

SUIVI DES SOINS DU NOUVEAU-NE MALADE

➤ PROBLEMES D'ALIMENTATION

Après 2 jours :

- Réévaluer l'alimentation. > Voir « **Rechercher les difficultés d'alimentation** »
- Poser des questions sur les problèmes d'alimentation notés lors de la première visite
 - Conseiller la mère sur tout problème d'alimentation nouveau ou persistant. Si vous conseillez à la mère d'apporter des changements sensibles à l'alimentation, lui conseiller de revenir pour une nouvelle visite de suivi.
 - Si le poids du nouveau-né est faible pour son âge, conseiller à la mère de revenir 7 jours après la première visite pour une nouvelle pesée.

Exception : Si **pas d'amélioration** ou si le nouveau-né a **perdu du poids**, le référer à l'hôpital.

➤ POIDS FAIBLE

Après 7 jours :

- Peser le nouveau-né et déterminer si son poids est toujours faible pour son âge.
- Réévaluer l'alimentation. > Voir « **Problèmes d'alimentation** » ci-dessus.
 - Si le poids du nouveau-né **n'est plus faible pour son âge**, féliciter la mère et l'encourager à continuer.
 - Si le poids du nouveau-né est **encore faible pour son âge, mais si le nouveau-né se nourrit bien**, féliciter la mère. Lui demander de revenir peser son nouveau-né chaque semaine.
 - Si le poids du nouveau-né est **encore faible pour son âge, et qu'il a toujours un problème d'alimentation**, conseiller la mère sur le problème d'alimentation. Lui demander de revenir dans 7 jours. Continuer le suivi du nouveau-né toutes les semaines jusqu'à ce qu'il se nourrisse bien et gagne du poids régulièrement, ou que son poids ne soit plus faible pour son âge.

Exception : Si **pas d'amélioration** ou si le nouveau-né a **perdu du poids**, le référer à l'hôpital.

➤ MUGUET

Après 5 jours :

- Rechercher les plaques blanches dans la bouche (muguet).
- Réévaluer l'alimentation. > Voir « **Problèmes d'alimentation** » ci-dessus.
 - Si **le muguet s'est aggravé**, ou si le nouveau-né a des **problèmes de succion et de prise du sein**, le référer à l'hôpital.
 - Si **le muguet n'a pas évolué ou a diminué**, et si le nouveau-né se **nourrit bien**, continuer le traitement à la nystatine pendant encore 5 jours

SUIVI DES SOINS DU NOUVEAU-NE MALADE

➤ **INFECTION VIH POSSIBLE/ EXPOSE AU VIH**

Après 7 jours :

➤ **Si la mère est séropositive connue au VIH :**

- Evaluer le niveau d'application des conseils donnés à la mère qui allaite.
- Evaluer l'alimentation. > Voir « **Rechercher les difficultés d'alimentation** ».
- Evaluer le poids du nouveau-né pour son âge : Si le poids est faible pour son âge, conseiller à la mère de revenir 7 jours plus tard pour une nouvelle pesée.
- Préparer la famille pour le début de la prophylaxie au Cotrimoxazole chez le nourrisson à partir de la 6e semaine de vie
- Se référer aux guides de prise en charge du VIH/SIDA chez l'adulte et chez l'enfant pour organiser les soins à la mère, à l'enfant et à toute la famille.
- Conseiller la mère sur l'importance des visites de suivi et le respect des consignes données par l'agent de santé.

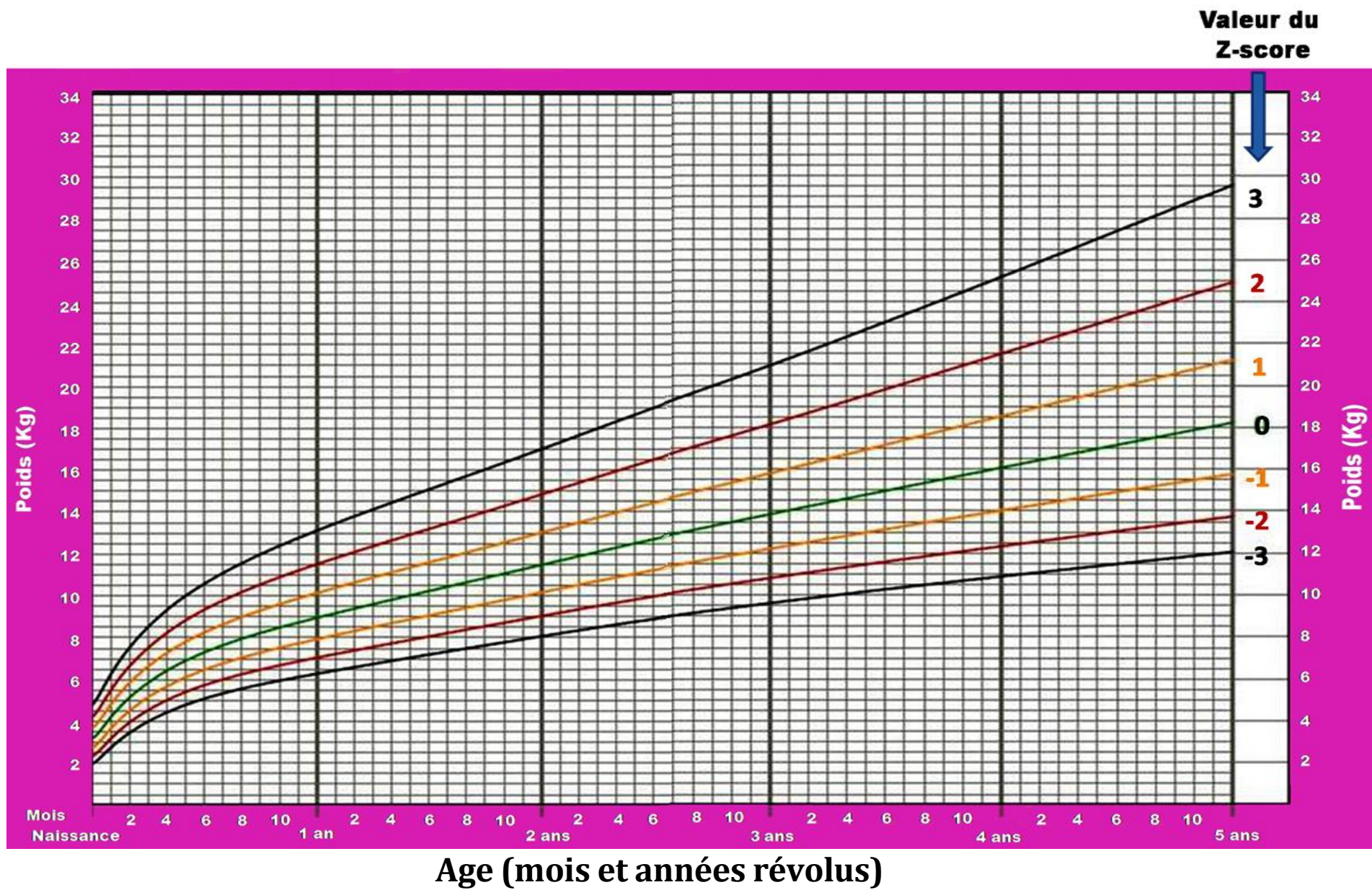
➤ **Si le statut sérologique VIH de la mère est inconnu**

- Rediscuter de l'avantage d'effectuer un test VIH : si la mère est consentante, prendre les dispositions pour le test et la visite de suivi.

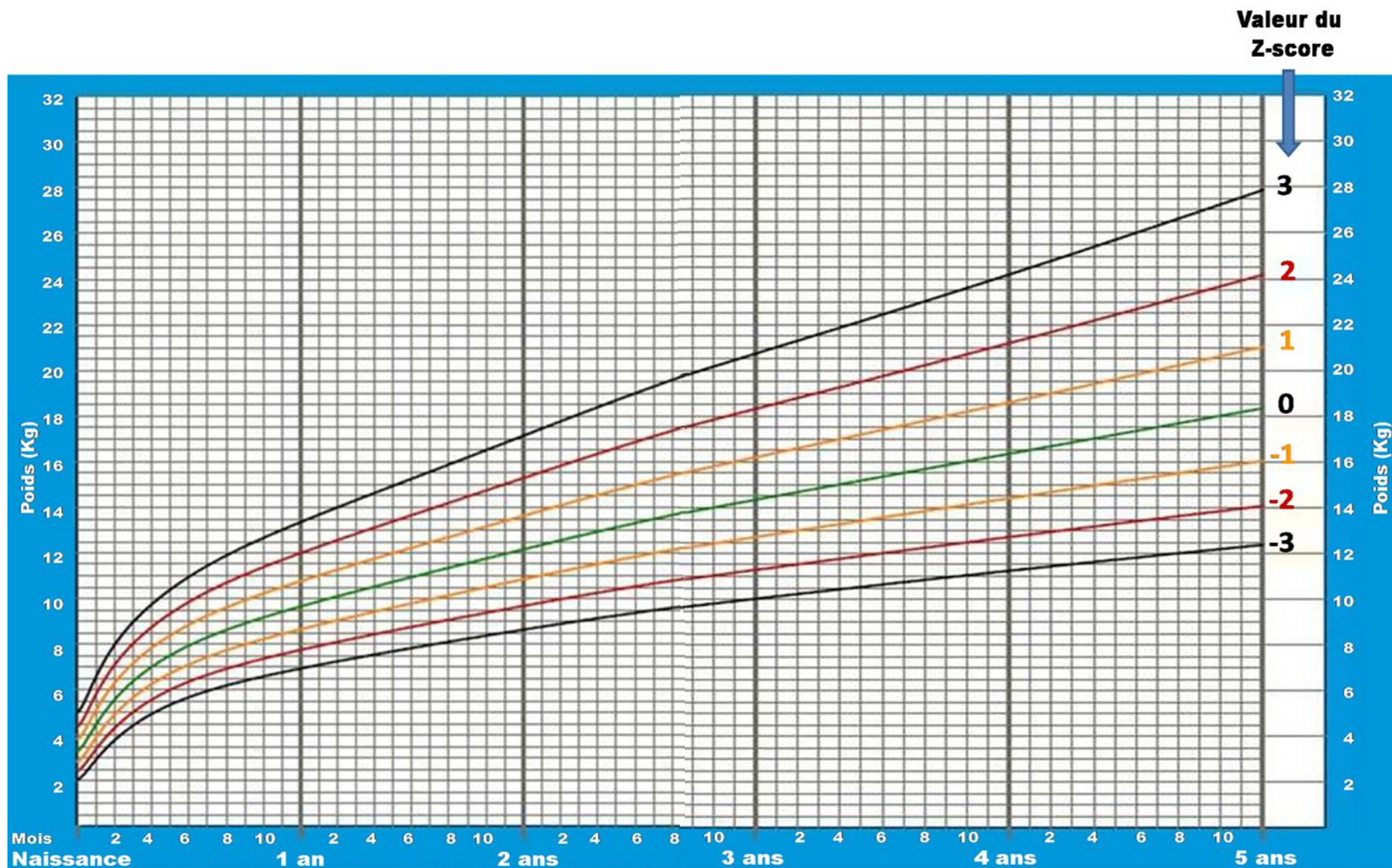
Exception : Si **pas d'amélioration** ou si le nouveau-né a **perdu du poids**, le référer à l'hôpital.

ANNEXE 1 : COURBES DE CROISSANCE

Poids pour l'âge : FILLES

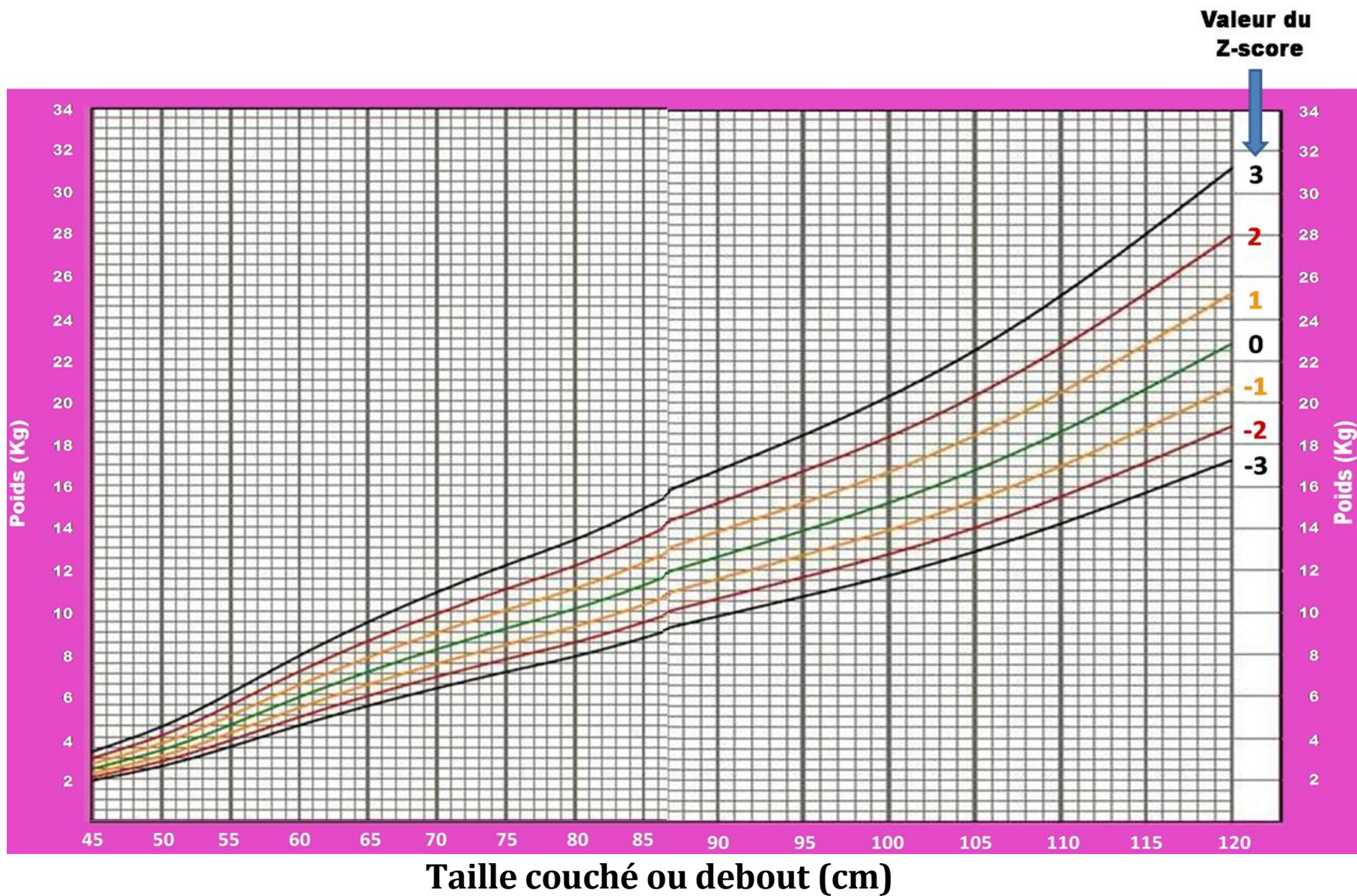


Poids pour l'âge : GARCONS

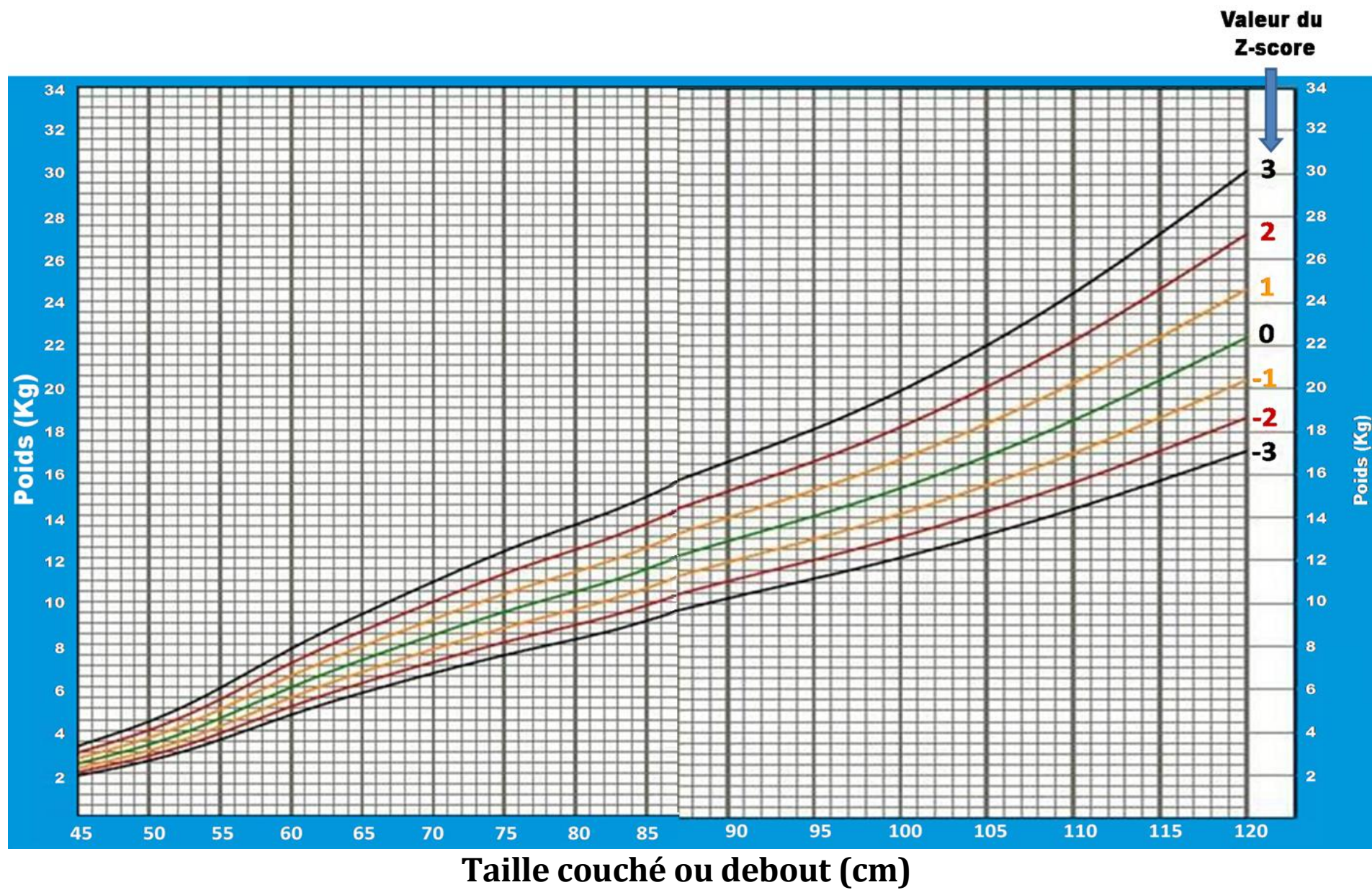


Age (mois et années révolus)

Poids pour la taille : FILLES



Poids pour la taille : GARCONS

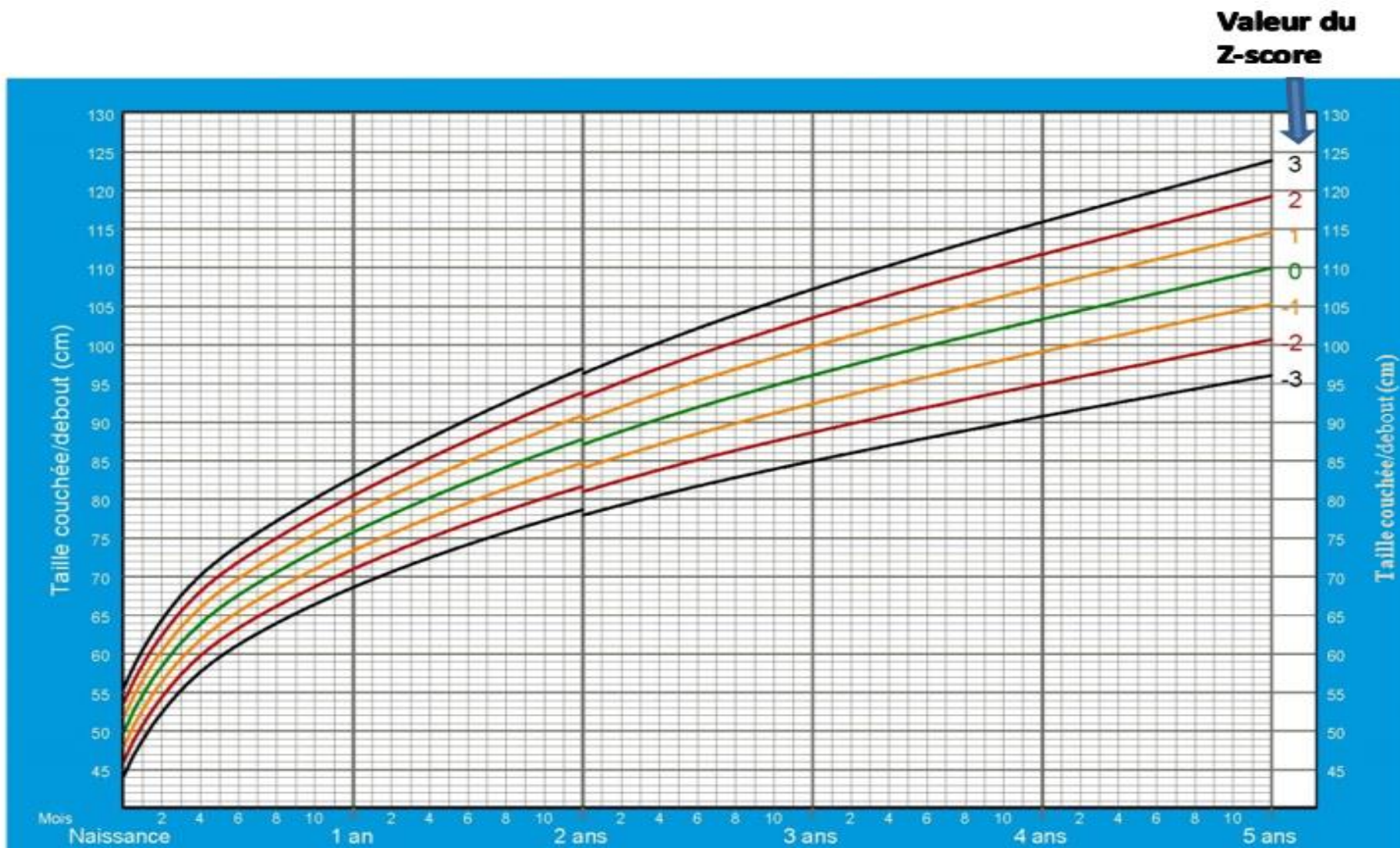


Taille pour âge : FILLES



Age (mois et années révolus)

Taille pour âge : GARÇONS



Age (mois et années révolus)

ANNEXE 2 : FICHES DE PRISE EN CHARGE

FICHE DE PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DE L'ENFANT AGE DE 2 MOIS A 5 ANS

Nom: _____ Age: _____ Poids: _____ kg Température: _____ °C Taille : _____ cm

DEMANDER: Quels sont les problèmes de l'enfant? _____

Première visite ? ____ Visite de suivi ? ____ Episode initial ? ____ Episode répété _____

EVALUER (entourer tous les signes présents)

CLASSER

RECHERCHER LES SIGNES GENERAUX DE DANGER L'ENFANT VOMIT TOUT CE QU'IL CONSOMME INCAPABLE DE BOIRE OU DE PRENDRE LE SEIN ANTECEDENT DE CONVULSIONS CONVULSIONS ACTUELLES LETHARGIQUE OU INCONSCIENT		Signe général de danger présent ? Oui___ Non___ Ne pas oublier d'utiliser le signe de danger lors de la classification
L'ENFANT TOUSSE-T-IL OU A-T-IL DES DIFFICULTES RESPIRATOIRES ? Oui___ Non___		
- Depuis combien de temps ? ____ Jours - Compter les mouvements respiratoires par minute. ____ mvts resp. par minute. Respiration rapide ? - Rechercher un tirage sous-costal. - Regarder et écouter le stridor.		
L'ENFANT A-T-IL LA DIARRHEE ? Oui___ Non___		
- Depuis combien de temps ? ____ Jours - diarrhée de 14 jours ou plus au cours des 3 derniers mois ? Oui___ Non___ Si diarrhée persistante actuelle ou diarrhée de 14 jours ou plus au cours des 3 derniers mois rechercher une infection symptomatique probable VIH - Ses selles contiennent-elles du sang ? - Evaluer l'état général de l'enfant. L'enfant est-il. Léthargique ou inconscient ? Agité ou irritable ? - Regarder si les yeux sont enfoncés. - Offrir à boire à l'enfant. L'enfant : Est-il incapable de boire ou boit-il difficilement ? Est-il assoiffé, boit-il avidement ? - Pincer la peau de l'abdomen de l'enfant. Le pli s'efface-t-il : Très lentement (plus de 2 secondes) ? Lentement ? Immédiatement ?		
L'ENFANT A-T-IL DE LA FIEVRE ? (antécédents/chaud au toucher/température de 38°C ou plus) Oui___ Non___		
- Depuis combien de temps ? ____ Jours - Si depuis plus de 7 jours, la fièvre a-t-elle été présente tous les jours ? Oui___ Non___ - L'enfant a-t-il eu la rougeole au cours des 3 derniers mois ? Oui___ Non___ - Observer et rechercher une raideur de la nuque - Demander observer et rechercher des signes de paludisme grave : - Urines peu abondantes et foncées (coca cola) - Ictère (yeux jaunes) - Hémorragies spontanées - Réaliser le TDR du paludisme : Négatif ? Positif ? - Rechercher les signes de ROUGEOLE : Eruption généralisée et l'un de ces signes : toux, écoulement nasal, ou yeux rouges.		
Si l'enfant a actuellement la rougeole ou l'a eue au cours des 3 derniers mois :		
- Regarder dans la bouche pour rechercher des ulcérations. Si elles sont présentes, sont-elles profondes et étendues ? - Regarder s'il y a du pus qui coule des yeux. - Regarder s'il existe une opacité de la cornée.		
L'ENFANT A-T-IL UN PROBLEME D'OREILLE ? Oui___ Non___		
- A-t-il des douleurs d'oreille ? - Y a-t-il un écoulement d'oreille ? - Si oui, depuis combien de temps ? ____ jours - Antécédent d'écoulement d'oreille ? Si oui, rechercher une ISPVIH - Regarder si du pus coule d'une oreille. Rechercher une ISPVIH - Palper l'arrière de l'oreille à la recherche d'un gonflement douloureux		
RECHERCHER LES SIGNES D'ANEMIE		
- Rechercher la pâleur palmaire. Est-elle Absente ? Légère ? Sévère ? - Si pâleur palmaire présente, demander : l'enfant est-il drépanocytaire ? Si oui rechercher les signes de gravité - Rechercher les signes cardiorespiratoires, neurologiques et autres signes		
RECHERCHER LES SIGNES DE MALNUTRITION		
L'enfant a-t-il perdu du poids ?		- Rechercher les oedèmes bilatéraux au niveau des membres supérieurs et inférieurs et du visage. - Déterminer le poids pour l'âge faible___ Pas faible___ - Déterminer le poids pour la taille faible___ Pas faible___ - Si poids faible, cassure de la courbe de poids ou perte de poids Rechercher une ISPVIH

RECHERCHER UNE INFECTION A VIH • Pneumonie actuelle ? • Diarrhée persistante actuelle ou dans les trois derniers mois ? • Amaigrissement visible et sévère ou poids faible pour l'âge ? • Ya-t-il un antécédent de tuberculose dans la famille ?		• Ecoulement d'oreille actuel ou au cours des 3 dernier mois ? • Cassure de la courbe de poids ou antécédent de perte de poids ? • Ganglions sur deux aires ganglionnaires ou plus : cervicales, axillaires, inguinales ? • Présence d'un muguet ? • Gonflement de la parotide ?	
VERIFIER L'ETAT VACCINAL		Indiquer les vaccinations reçues et entourer les vaccinations à faire aujourd'hui.	Ramener l'enfant pour la prochaine vaccination le:
BCG (DTC-HepB-Hib-Rota- PCV13) 1 (DTC-HepB-Hib- Rota- PCV13) 2 (DTC-HepB-Hib- Rota- PCV13) 3 + VPI			
Polio 0 Polio 1 Polio 2 Polio 3 RR Fièvre jaune MenA			(Date)
VERIFIER LA SUPPLEMENTATION EN VITAMINE A			Prochaine supplémentation en vitamine A le:
Date de la dernière prise _____		Entourer s'il faut donner de la Vitamine A aujourd'hui	(Date)
VERIFIER LE DEPARASITAGE			Prochain déparasitage le :
Date de la dernière prise _____		Entourer s'il faut déparasiter aujourd'hui	(Date)
EVALUER L'ALIMENTATION DE L'ENFANT SI : l'enfant est ANEMIE OU A UNE MALNUTRITION MODEREE ou a moins de 2 ans.		Problèmes d'alimentation	
• Allaitiez-vous l'enfant? Oui _____ Non _____ Si oui, combien de fois par jour? ____ Fois. Allaitiez-vous pendant la nuit? Oui _____ Non _____ • L'enfant consomme-t-il d'autres aliments et liquides? Oui _____ Non _____. Si oui, quels aliments ou quels liquides? _____ Combien de fois par jour ?fois Comment donnez-vous à manger à l'enfant ? _____ Si poids faible pour son âge et/ou pour la taille : L'enfant mange-t-il à satiété ? _____			
• L'enfant reçoit-il sa propre part ? _____ Qui fait manger l'enfant et comment ? _____ Pendant sa maladie, l'alimentation de l'enfant a-t-il changé ? Oui _____ Non _____, Si oui, Comment ? _____			
EVALUER LES AUTRES PROBLEMES			
VERIFIER L'ETAT DE SANTE DE LA MERE			

N'oubliez pas de transférer tout enfant qui présente un signe de danger même s'il n'a pas d'autres classifications graves

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Revenir pour une visite de suivi le:.....

Expliquer à la mère quand revenir immédiatement.....

Faire les vaccins nécessaires aujourd'hui :

Donner la Vitamine A :

Conseils pour l'alimentation.....

FICHE DE PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DU NOURRISSON AGE DE 1 SEMAINE A 2 MOIS

Nom : ----- Age : ----- Poids : -----Kg Taille :cm Température : -----C°

DEMANDER : Quels sont les problèmes du nourrisson ? -----

Première visite ? ----- Visite de suivi ? ----- Episode initial ? ----- Episode répété ? -----

EVALUER (Entourer tous les signes présents)

CLASSER

RECHERCHER L'INFECTION BACTERIENNE EVENTUELLE

- Le nourrisson a-t-il eu des convulsions ?
 - Compter les mouvements respiratoires. ----- par minute.
Recompte si le nombre > ou = à 60 ----- Respiration rapide ?
 - ATCD de ou difficultés à se nourrir
 - Rechercher un tirage sous - costal marqué.
 - Regarder et écouter le geignement expiratoire.
 - Fièvre (température de 38° C ou plus),
 - Hypothermie (au dessous de 36° C)
 - Regarder si le nourrisson bouge seulement s'il est stimulé.
 - Omphalite - Pustules cutanées

LE NOURRISSON A-T-IL LA DIARRHEE ? Oui ----- Non-----

- Depuis combien de temps ? -----jours
- Y a-t-il du sang dans les selles ?
- Evaluer l'état général du nourrisson. Est-il :
Léthargique ou inconscient ?
Agité ou irrité ?
- Regarder si ses deux yeux sont enfoncés.
- Pincer la peau de l'abdomen. Le pli s'efface-t-il :
Très lentement (plus de 2 secondes) ?
Lentement ? Immédiatement ?

PUIS RECHERCHER LES PROBLEMES D'ALIMENTATION OU D'INSUFFISANCE PONDERALE

- Existe-t-il des problèmes d'alimentation ? • Déterminer le poids pour son âge. Faible ----- Normale -----
 Oui ----- Non----- Déterminer le poids pour sa taille. Faible ----- Normale -----
- Le nourrisson est-il allaité? Oui ----Non -----
 Si oui combien de fois en 24 heures ? ----- fois
- Le nourrisson reçoit-il d'habitude d'autres aliments ou liquides ? Oui ----- Non-----
 Si oui combien de fois ?..... Et lesquels ?.....
- Comment sont donnés les aliments ?.....

Si le nourrisson a des difficultés à se nourrir, est alimenté moins de 8 fois en 24 heures, consomme d'autres aliments ou liquides, ou est d'un poids faible pour son âge et/ou pour sa taille, et ne présente aucun signe justifiant son transfert à l'hôpital :

EVALUER L'ALLAITEMENT:

- Le nourrisson a-t-il été allaité pendant l'heure précédente ?
- Si le nourrisson n'a pas été allaité pendant l'heure précédente, demander à la mère de mettre le nourrisson au sein. Observer l'allaitement pendant 4 minutes.
- Le nourrisson peut-il bien prendre le sein ? Pour vérifier la bonne prise du sein, regarder si :
 - Le menton touche le sein Oui ----- Non -----
 - La bouche est grande ouverte Oui ----- Non -----
 - La lèvre inférieure est éversée vers l'extérieur Oui ----- Non -----
 - Plus d'aréole au-dessus qu'en dessous Oui ----- Non -----
- Pas de prise du tout - Prise non efficace - Prise efficace*
- Est-ce que le nourrisson tète efficacement (c'est-à-dire succion lente et profonde avec pauses)
- Pas de succion du tout - Succion non efficace - Succion efficace*
- Regarder la bouche pour détecter des ulcérations ou des plaques blanches (muguet)

EVALUER LE NOURRISSON POUR L'INFECTION VIH

- La mère a-t-elle son test VIH ? Oui..... Non.....
- Quel était le résultat du test ? Positif - Négatif

VERIFIER L'ETAT VACCINAL

Entourer les vaccinations à faire aujourd'hui.

BCG

(DTC-HepB-Hib – Rota- PCV13) 1

Polio 0

Polio 1

TRAITER

N'oubliez pas de transférer tout enfant qui présente un signe de danger même s'il n'a pas d'autres classifications graves

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Revenir pour visite de suivi le:.....

Vaccins administrés aujourd'hui :

Donner la Vitamine A à la mère :

Expliquer à la mère quand revenir immédiatement.....

Conseils pour l'alimentation.....

FICHE DE PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DU NOUVEAU-NE AGE DE 0 A 1 SEMAINE

Nom : _____ Sexe : _____ Age : _____ Poids : _____ kg Taille _____ cm
 Périmètre crânien _____ cm Température : _____ °C
Demander : Quels sont les problèmes du nouveau-né ? _____ Première visite ? _____ Visite de suivi ? _____

ÉVALUER (entourer tous les signes présents)	CLASSER
RECHERCHER UNE MALADIE GRAVE OU INFECTION BACTERIENNE GRAVE Le nouveau-né est-il léthargique ? Le nouveau-né a-t-il eu des convulsions ? Le nouveau-né convulse t-il actuellement ? Le nouveau-né est-il incapable de s'alimenter ? Compter les mouvements respiratoires _____ par minute Recompter si le nombre de mouvements respiratoires est élevé _____ respiration rapide (> 60 / minute) ? respiration lente (<30/minute) ou pause>30 secondes? Rechercher un tirage sous costal marqué Rechercher un geignement expiratoire La température est-elle > 37,5°C ? La température est-elle < 35,5°C ? Le nouveau-né ne fait pas de mouvements même si on le stimule ? Le nouveau-né ne bouge que seulement quand on le stimule ? Les pustules cutanées sont elles nombreuses et / ou sévères ? Le nouveau-né a-t-il un ictère précoce ? Le nouveau-né a-t-il une pâleur sévère ? Le nouveau-né a-t-il une cyanose généralisée ? Le nouveau-né a-t-il une rougeur ombilicale s'étendant à la région périombilicale?	
RECHERCHER UNE HYPOTHERMIE MODEREE La température est-elle comprise entre 35,5°C et 36,5°C ?	
RECHERCHER UNE INFECTION BACTERIENNE LOCALE Regarder l'ombilic. Est-il rouge ou purulent ? Regarder la peau pour détecter les pustules.	
RECHERCHER UNE INFECTION OCULAIRE Le bébé a-t-il les yeux purulents ? Le bébé a-t-il les yeux enflés ?	
RECHERCHER UN POIDS FAIBLE Poids de naissance < 1500 g Poids de naissance compris entre 1500g et 2500g	
RECHERCHER UNE INFECTION VIH POSSIBLE La mère est-elle séropositive connue au VIH ? La sérologie VIH de la mère est-elle inconnue? La sérologie VIH de la mère était elle négative?	
RECHERCHER LES PROBLEMES D'ALIMENTATION . Le nouveau-né a-t-il des difficultés à s'alimenter ? oui__ non__ . Le nouveau-né est-il allaité au sein ? oui__ non__ Si non, évaluer l'alimentation de remplacement Si oui, combien de fois en 24 heures ? _____ fois . Le nouveau-né reçoit-il d'habitude d'autres aliments ou liquides ? oui__ non__ Si oui, combien de fois par jour? . Comment sont donnés les aliments ? Si le nouveau-né a des difficultés à se nourrir, est alimenté moins de 12 fois en 24 heures, consomme d'autres aliments ou liquides, et ne présente aucun signe justifiant sa référence d'urgence à l'hôpital, Alors : ----- Evaluer l'allaitement : Le nouveau-né a-t-il été allaité pendant l'heure précédente ? Oui----- Non----- Si le nouveau-né n'a pas été allaité pendant l'heure précédente, demander à la mère de mettre le nouveau-né au sein. Observer l'allaitement pendant 4 minutes : - Le nouveau-né peut-il bien prendre le sein ? Pour vérifier la bonne prise de sein, regarder si : - Le menton touche le sein oui__ non__ - La bouche est grandement ouverte oui__ non__ - La lèvre inférieure est éversée oui__ non__ - Plus d'aréole au dessus qu'en dessous oui__ non__ Pas de prise de sein mauvaise prise de sein bonne prise de sein - Est-ce que le nouveau-né tète efficacement (c'est à dire succion lente et profonde avec pauses) ? Pas de succion du tout succion non efficace succion efficace - Regarder la bouche pour détecter le muguet Evaluer l'alimentation de remplacement : - Vérifier si les conditions AFADS sont remplies - Vérifier la préparation du lait (dilution, dosage) - Vérifier le nombre de repas	
VERIFIER L'ETAT VACCINAL Entourer les vaccinations à faire aujourd'hui BCG Polio 0	Ramener l'enfant pour la prochaine vaccination le : _____ (date)
ÉVALUER LES AUTRES PROBLEMES	

TRAITER

N'oubliez pas de transférer tout enfant qui présente un signe de danger même s'il n'a pas d'autres classifications graves

Revenir pour une visite de suivi le:.....

Expliquer à la mère quand revenir immédiatement.....

Faire les vaccins nécessaires aujourd'hui :

Conseils pour maintenir le nouveau-né au chaud :.....

Conseils pour l'alimentation.....

Avec l'appui technique et financier de nos Partenaires :



Pour des informations complémentaires veuillez contacter :

Le Programme National de Santé de la Mère et de l'Enfant (PNSME)

Tél : 20 21 22 21/20 32 24 63

Email : dcpnsr@gmail.com

Imprimé en Côte d'Ivoire – Abidjan,